مشروع وصول "2"

تقرير المراجعة الفنية في نصف المدة

د. عبد الحميد كابش

إستشاري الطب الطبيعي و التأهيل

مستشار صندوق "عطاء"

أكتوبر - 2023

فهرس المحتويات

الموضوع	الصفحة
مقدمة	3
الهدف من المراجعة	3
عملية المراجعة	3
أولاً: التقرير العام	4
1. نظام العمل الفني	4
1.1. الإدارة الفنية	4
1.1.1. هيكلية الإدارة الفنية	4
1.1.2. وظائف فريق الإدارة الفنية	4
1.1.3. المستوى الفني لفريق الإدارة الفنية	5
1.2. تقديم الخدمات الفنية	6
1.2.1. هيكلية تقديم الخدمات الفنية	6
1.2.2. وظائف فريق تقديم الخدمات الفنية	6
1.2.3. المستوى الفني لفريق تقديم الخدمات الفنية	6
2. أسلوب و سير العمل	7
2.1. كفاءة الخدمات الفنية	7
2.1.1. العمل مع الفئات العمرية المختلفة من الجنسين	7
2.1.2. العمل مع أنواع الإعاقات المختلفة	7
2.1.3. أنواع الجلسات و الخدمات المقدمة:	10
2.1.4. تقييم الأطفال و حالات الزيارات المنزلية	12
2.1.5. وضع خطط التدخل	12
2.1.6. وضع أهداف الجلسات و تنفيذها	13
2.1.6.1. الجلسات داخل وحدة التأهيل المرتكز على المجتمع	13
2.1.6.2. الجلسات \ الزيارات المنزلية	13
2.1.7. تقييم تقدم الأشخاص ذوي الإعاقة	14
2.1.7.1. تقييم تقدم الأطفال الذين يتلقون جلسات في الوحدة	14
2.1.7.2. تقييم تقدم الأشخاص الذين يتلقون زيارات منزلية	15
2.1.8. تقييم الجلسات و أداء مسؤولات التأهيل	16
2.1.9. تسجيل أنشطة الوحدة	16
2.1.10. الإتاحة الفيزيقية	17
2.1.11. إجراءات الأمن و السلامة و الحماية و الشكاوى	17
2.2. فاعلية الخدمات الفنية	18
2.2.1. أعداد المستفيدين	18
2.2.2. التحسن في حالات المستفيدين	18
2.2.2.1. المستفيدون من الجلسات المنفذة في وحدات التأهيل المرتكز على المجتمع	18
2.2.2.2. المستفيدون من الزيارات المنزلية	18
2.2.2.3. المستفيدون من الأنشطة الدامجة و التوعوية	19
2.2.2.4. الأمهات	19
ثانياً: تقارير الوحدات	20

(أ) تقرير وحدة المنشأة في سوهاج	21
(ب)تقرير وحدة فرازة في أسيوط	26
(ج) تقرير وحدة كوم المنصورة في أسيوط	32
3. أهم الخلاصات و التوصيات	38
4. ملاحق	42

مقدمـــــــــــــــــــــــة

مشروع "وصول – 2" هو أحد مشروعات جمعية "كيان" التي تنفذها في صعيد مصر بتوجه التأهيل المرتكز على المجتمع و سعياً للتنمية الشاملة الدامجة، ينفذ المشروع بالشراكة مع صندوق "عطاء" الذي يدعم المشروع مالياً و فنياً.

يتم تنفيذ المشروع من خلال (30) وحدة للتأهيل المرتكز على المجتمع في محافظات سوهاج و أسيوط و بني سويف، يستمر المشروع لمدة عامين و يهدف إلى تأهيل و دمج 4850 من الأشخاص ذوي الإعاقة، و تعزيز مشاركتهم في الأنشطة المجتمعية، و تحسين جودة و نوعية الخدمات المقدمة لهم من خلال بناء التعاون و الشراكات مع مقدمي الخدمات في المجالات الصحية و التعليمية و الإجتماعية و الشبابية و الثقافية و الترويحية.

الهدف من المراجعة:

تمت المراجعة بهدف تقويم الأداء الفني لوحدات التأهيل المرتكز على المجتمع، بغرض تطوير أداءاتها و تحسين جودتها في الفترة الباقية من المشروع، و الاستفادة من النتائج و التوصيات في المشروعات المستقبلية.

عملية المراجعة:

تمت المراجعة خلال شهر أكتوبر 2023 و تضمنت:

- الإطلاع على وثائق و تقارير المشروع مثل المقترح و الإطار المنطقي و التوصيف الوظيفي لفريق العمل الفني و تقارير عن عينة من الأطفال المستفيدين و عينة من التسجيل الإلكتروني لإحدى الوحدات و قواعد البيانات و الاستمارات و الأدوات المستخدمة و معايير الجودة الخاصة بالمشروع.
- إعداد أدوات المراجعة التي تضمنت أدوات:
  - ملاحظة جلسات التدخل الفردية.
  - مقابلات فردية مع مسؤولات التأهيل
  - مقابلات جماعية مع أمهات يحصلن على زيارات منزلية
  - مقابلات جماعية مع أمهات يشاركن في الأنشطة الدامجة
- زيارات ميدانية لثلاث وحدات تأهيل مرتكز على المجتمع في كل من في كل من:
  - "المنشأة" في سوهاج.
  - "فرازة" في مركز القوصية - أسيوط
  - "كوم المنصورة" في مركز أبنوب - أسيوط

اشتملت كل زيارة على ملاحظة (2-3) جلسات فردية و مقابلة مسؤولات التأهيل (2-3)، منسقي التأهيل، و المشرفين الفنيين (في كل وحدة)، و المديرين الفنيين (في كل محافظة) و المدير الفني و مدير المشروع، و أمهات و مقدمي الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة. (مقابلات فردية و جماعية).

- تجميع البيانات و المعلومات

- وضع هيكلية التقرير و التي شملت:
  - أولاً: التقرير العام و الذي تضمن مقدمة عن نظام العمل الفني، الهيكلية و الوظائف و المستوى الفني لكل من الإدارة الفنية و تقديم الخدمات الفنية، أسلوب و سير العمل و الذي يشمل كفاءة و فاعلية الخدمات الفنية بعناصرهما المختلفة، انتهاءً بأهم النتائج و التوصيات.
  - ثانياً: تقارير مفردة عن كل من الوحدات الثلاثة.
- تحليل البيانات و كتابة التقرير

أولاً: التقرير العام

1. نظام العمل الفني:

يتم العمل في مشروع "وصول 2" طبقاً لنظام محدد للإدارة الفنية و لتقديم الخدمات الفنية.

1.1. إدارة العمل الفني:

1.1.1. هيكلية الإدارة الفنية: (مرفق تكوين الفريق الفني)

يتكون هيكل الإدارة الفنية كالتالي:

مدير المشروع (أ. سيد		
المدير الفني للمشروع (أ. هدى أبو اليزيد)		
مكتب سوهاج	مكتب منفلوط	مكتب أسيوط
مديرو المكاتب		
أحمد عرفة	سيد عبد اللطيف	مروة يوسف
المدراء الفنيون للمكاتب		
آية صلاح (تشرف على 5 وحدات في سوهاج)	هدى أبو اليزيد (تشرف على 15 وحدة في أسيوط)	صفية عبد المنعم (تشرف على 6 وحدات في منفلوط)
منسقو المشروع		
سناء خليفة (تشرف على 5 وحدات في سوهاج و 15 في أسيوط)	آيات علي (تشرف على 6 وحدات في منفلوط و 4 وحدات في بني سويف)	سناء خليفة (تشرف على 5 وحدات في سوهاج و 15 في أسيوط)
منسقو التأهيل بالمكاتب		
محمود فرغل	سناء خليفة	آيات علي
المشرفون الفنيون للوحدات		
فاطمة عبد العزيز	مصطفى صابر	هدير أحمد
مسؤولات التأهيل (3 في كل وحدة)		

1.1.2. وظائف فريق الإدارة الفنية: (مرفق التوظيف الوظيفي لفريق المشروع)

- **مدير المشروع**

- **المدير الفني للمشروع**
- **مديرو المكاتب**
- **المدراء الفنيون للمكاتب**
- **منسقو المشروع بالمكاتب**
- **منسقو التأهيل بالمكاتب**
- **المشرفون الفنيون بالمكاتب**

= يوفر هيكل فريق الإدارة الفنية تواصلاً جيداً و تفاعلاً يساعد على العمل الجماعي الفعّال و المتسق و المنسق بين المستويات المختلفة للإدارة الفنية، و يمكّن من تحقيق مستوى جيد للعمل من تخطيط و تنفيذ و متابعة و إشراف.
= يبدو عبء العمل لدى أعضاء فريق الإدارة الفنية كبيراً؛ نظراً لحجم العمل في المشروع من جهة و قلة عدد أعضاء الفريق نسبياً من جهة أخرى، فيقوم بعض الأعضاء بعدة أدوار مهمة و كبيرة في نفس الوقت، و على سبيل المثال:

- مدير المشروع هو مدير مكتب منفلوط
- المدير الفني للمشروع هي المدير الفني لمكتب أسيوط و تشرف على (15) وحدة في أسيوط
- منسقات المشروع تشرف كل منهما على مكتبين في نفس الوقت (سوهاج مع أسيوط) و (بني سويف مع منفلوط) و هن أيضاً منسقات التأهيل بمكتب أسيوط و سوهاج.

= يتحمل المديرون الفنيون على مستوى المحافظات أعباءً فنية إضافية مرتبطة بكونهم خبراء في بعض مجالات الخدمات الفنية المتخصصة، مثل الوحدات المتخصصة لمونتسوري و التكامل الحسي؛ و لكل منها مسؤوليات فنية مهمة و كبيرة.

1.1.3. المستوى الفني لفريق الإدارة الفنية:

- المستوى الفني **لمدير المشروع و المدير الفني للمشروع** ممتاز و يعتبر من أعلى المستويات المتواجدة في ميدان العمل في مجال الإعاقة و خاصة في مجال التأهيل المرتكز على المجتمع، و لديهما خبرة فنية قوية و طويلة في العمل الفني و في الإدارة الفنية، و يؤديان عملهما بكفاءة عالية.
- المستوى الفني **للمديرين الفنيين للمكاتب** جيد جداً إلى ممتاز ، من خلال الحصول على الكثير من التدريبات و تكوين خبرات قوية من خلال العمل في كيان و خارجها و اتقان أحد التخصصات المهمة في مجال التأهيل (مثل التكامل الحسي و مونتسوري)، و المستوى الفني يناسب أداء المهام الوظيفية بكفاءة.
- المستوى الفني **للمشرفين الفنيين** جيد إلى جيد جداً، من خلال مؤهلات مناسبة و الحصول على الكثير من التدريب (بورتيدج، تعديل سلوك، اختبار فاينلاند، اختبار الذكاء، التكامل الحسي، و غير ذلك)، و تكوين خبرات قوية من خلال العمل في كيان و خارجها، و المستوى الفني بشكل عام يناسب أداء طبيعة المهام الوظيفية بكفاءة.
- المستوى الفني **لمنسقي المشروع** جيد جداً، و إن كانت إحداهما حديثة العهد بالعمل في مجال الإعاقة، و قد حصلتا على تدريبات مناسبة، و إحداهما لديها خبرة طويلة في نفس النوع من المشروعات، و المستوى الفني بشكل عام يناسب أداء طبيعة المهام الوظيفية بكفاءة.

- المستوى الفني **لمنسقي التأهيل** جيد إلى جيد جداً، من خلال الحصول على تدريبات و تكوين خبرات داخل و خارج "كيان"، و المستوى الفني بشكل عام يناسب أداء طبيعة المهام الوظيفية بكفاءة.
= يوفر المستوى الفني لأعضاء فريق الإدارة الفنية - خاصة المستويات الأعلى في الإدارة - الكفاءات القادرة على إدارة الجوانب الفنية للمشروع بشكل كفء و فعّال.

❖ **يحتاج بعض أعضاء فريق الإدارة الفنية - خاصة المستويات الوسطى - لمزيد من بناء القدرات و الكفاءات من خلال بعض التدريبات المتخصصة و اكتساب المزيد من الخبرات على رأس العمل.**

1.2. تقديم الخدمات الفنية:

1.2.1. هيكلية تقديم الخدمات الفنية:

يتم تقديم الخدمات الفنية للمشروع بواسطة مسؤولات التأهيل (ثلاث مسؤولات تأهيل لكل وحدة من وحدات التأهيل المرتكز على المجتمع)، و مسؤولات التأهيل هن المسؤولات عن تقديم أنواع الجلسات المختلفة في الوحدة (في حدود 10 أطفال لكل مسؤولة) ثلاثة أيام أسبوعياً، و تقديم الزيارات المنزلية ثلاثة أيام أسبوعياً (في حدود 30 زيارة شهرياً ل 15 حالة بواقع زيارتين لكل حالة شهرياً). (التفاصيل في الوصف الوظيفي)، و هن يعملن ستة أيام كل أسبوع من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثانية ظهراً، تحت الإشراف الفني للمشرفين الفنيين، و ينسق عملهن منسقي التأهيل.

1.2.2. وظائف فريق تقديم الخدمات الفنية: (مرفق التوظيف الوظيفي لفريق المشروع)

تقوم مسؤولات التأهيل بالوظائف التالية:

- تقييم حالات الأشخاص ذوي الإعاقة؛ باستخدام أدوات مختلفة (مثل .. قائمة بورتيدج، قوائم حسية، قوائم ضمنية، و غيرها .. للأطفال المستفيدين من الجلسات في وحدات التأهيل، و قائمة الاحتياجات في أدلة الصحة العالمية).
- تقديم الجلسات الفردية للأطفال ذوي الإعاقة في وحدات التأهيل (مثل .. جلسات بورتدج، تنمية المهارات اللغوية أو الحركية، تعديل السلوك، المهارات الأكاديمية، و غيرها)
- تقديم الزيارات المنزلية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون الذهاب إلى الوحدات أو الذين يكون من الأفضل لهم و لأسرهم أن يحصلوا على جلساتهم في المنزل.
- تنفيذ الأنشطة الدامجة و التوعوية مثل الجولات الحرة و الرحلات و الندوات .. مع الأشخاص ذوي الإعاقة و أسرهم و أعضاء المجتمع.

1.2.3. المستوى الفني لفريق تقديم الخدمات الفنية:

المستوى الفني **لمسؤولات التأهيل** بشكل عام جيد، و قد حصل أغلبهن على (35) يوم تدريب مقسمة على عدة مراحل، شملت التدريبات (التأهيل المرتكز على المجتمع، تأهيل الاعاقات المختلفة؛ حركية و ذهنية و بصرية و سمعية و صعوبات تعلم، إدارة الجلسات، الزيارات المنزلية، حماية الطفل ..)، كما يحصلن على تدريبات تنشيطية و تدريبات على رأس العمل، و المستوى الفني بشكل عام يناسب تنفيذ المهام الوظيفية المطلوبة منهن.

- **أظهرت غالبية مسؤولات التأهيل مستوى جيد إلى جيد جداً من الكفاءة في تقديم الجلسات و كان متوسط درجة الجودة باستخدام أداة التقييم المستخدمة في هذه المراجعة هي (78,1 %) لمسؤولات وحدة "المنشأة بسوهاج"، (77,9%) لمسؤولات وحدة "فرازة بأسيوط"، و إن كان هذا المتوسط مقبولاً في وحدة "كوم المنصورة بأسيوط" إذ كان (61.7%) فقط؛ حيث أن المسؤولات هناك بدأن العمل من شهور قليلة و لم يكملن بعد تدريبهن الأساسي.**
- **هناك احتياج لاستكمال تدريب مسؤولات التأهيل في كوم المنصورة، و أي مسؤولات في المشروع لم يتممن تدريبهم الأساسي.**

2. أسلوب و سير العمل:

2.1. كفاءة الخدمات الفنية:

2.1.1. العمل مع الفئات العمرية المختلفة من الجنسين:

- **يعمل المشروع مع الأشخاص ذوي الإعاقة من الجنسين في فئتي الأطفال و البالغين بشكل متوازن جداً.**

إذ تبلغ نسبة المستفيدين من الذكور (49,5%) و من الإناث (51,5%)، و من الأطفال (43,5%) و من البالغين (56,5%).

تخدم وحدة المنشأة 63 (53%) من الذكور و 56 (47%) من الإناث، و 58 (49%) من الأطفال و 61 (51%) من البالغين.

تخدم وحدة فرازة 72 (55%) من الذكور و 58 (45%) من الإناث، و 39 ((30%) من الأطفال و 91 (70%) من البالغين.

تخدم وحدة كوم المنصورة 61 (42%) من الذكور و 85 (58%) من الإناث، و 75 (51%) من الأطفال و 71 (49%) من البالغين.

(بناءً على قاعدة بيانات المشروع)

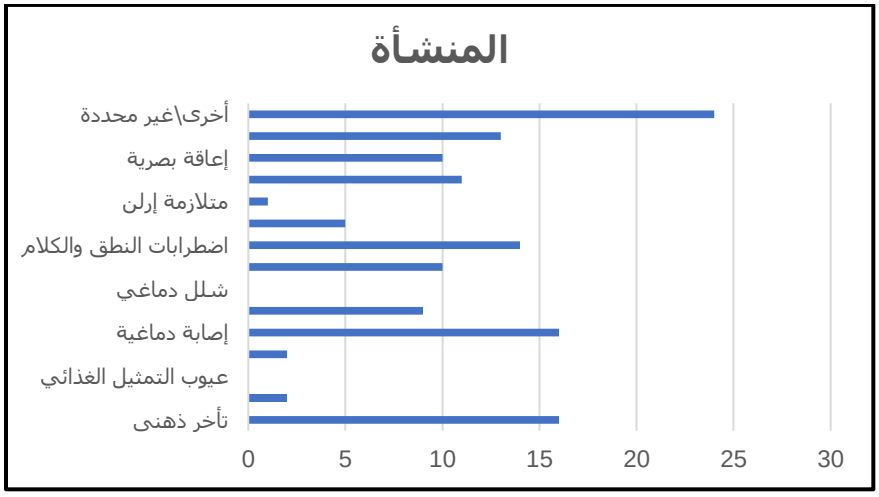
2.1.2. العمل مع أنواع الإعاقات المختلفة:

- تتضمن أنواع الإعاقات: تأخر ذهني، تأخر لغوي، صعوبات تعلم (قد تكون هناك صعوبات في التشخيص المعطى لبعض الحالات)، توحد (قد تكون هناك صعوبات في التشخيص المعطى لبعض الحالات)، تشتت انتباه و فرط حركة، اعاقات سمعية، اعاقات حركية.
- و تختلف نسب الحالات المختلفة ، كما تختلف أنواع الإعاقة التي يتم رصدها داخل كل وحدة و بين الوحدات المختلفة ، بشكل كبير و غير واضح السبب .. فمثلاً عدد حالات التأخر الذهني في كفر

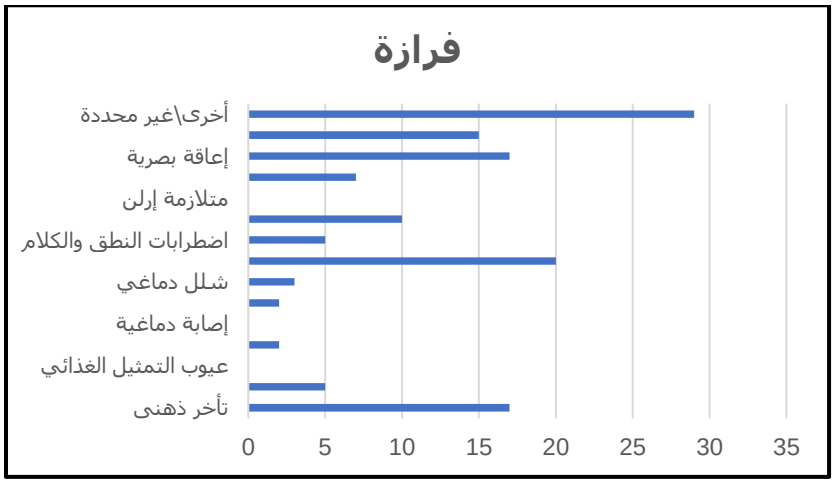
المنصورة (65) كبير جداً بالمقارنة بالمنشأة (16) و فرازة (17)، و عدد حالات الإصابة الدماغية في المنشأة (16) كبير جداً بالمقارنة بفرازة (0) و كوم المنصورة (0)، و عدد حالات ضمور العضلات بالمنشأة (9) كبير جداً بالمقارنة بفرازة (2) و كوم المنصورة (1)، و عدد حالات الشلل الدماغي في كوم المنصورة (15) كبير جداً بالمقارنة ب فرازة (3) و المنشأة (0)، و عدد حالات صعوبات التعلم في كوم المنصورة (1) قليل جداً بالمقارنة بالمنشأة (10) و فرازة (29) ، و كذا حالات اضطرابات النطق و الكلام في كوم المننصورة (0) قليلة جداً بلمقارنة بالمنشأة (14) ، و عدد الحالات غير المحددة في كوم المنصورة (52) كبير جداً بالمقارنة بالمنشأة (24) و فرازة (29) ..

نوع الإعاقة	المنشأة	فرازة	كوم المنصورة	المجموع
تأخر ذهنى	16	17	65	98
متلازمة داون	2	5	1	8
عيوب التمثيل الغذائي	0	0	2	2
اضطراب التوحد	2	2	1	5
إصابة دماغية	16	0	0	16
ضمور العضلات	9	2	1	12
شلل دماغي	0	3	15	18
اضطراب التعلم المحدد (صعوبات التعلم)	10	20	1	31
اضطرابات النطق والكلام	14	5	0	19
اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه	5	10	6	21
متلازمة إرلن	1	0	0	1
إعاقة سمعية	11	7	7	25
إعاقة بصرية	10	17	18	45
إعاقات متعددة	13	15	17	45
أخرى\غير محددة	24	29	52	105
المجموع	133	132	186	451

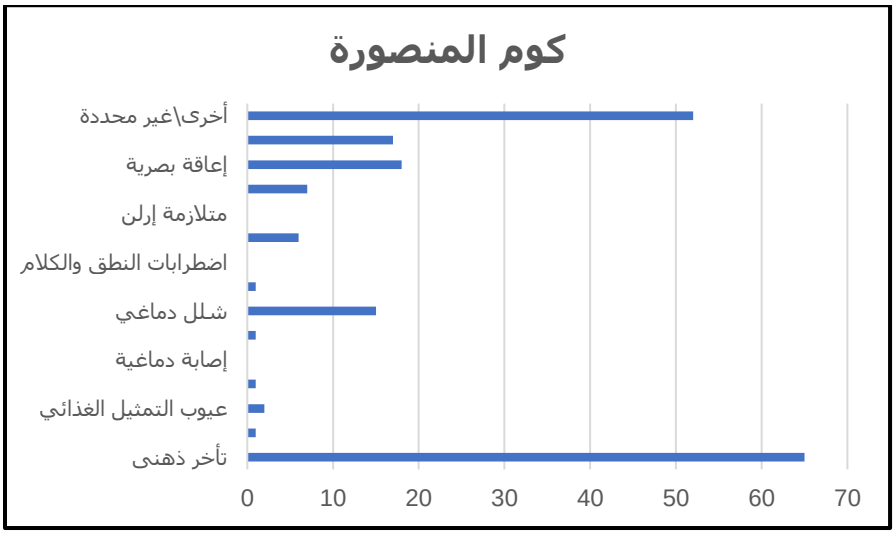
أعداد الحالات المختلفة في الوحدات الثلاث



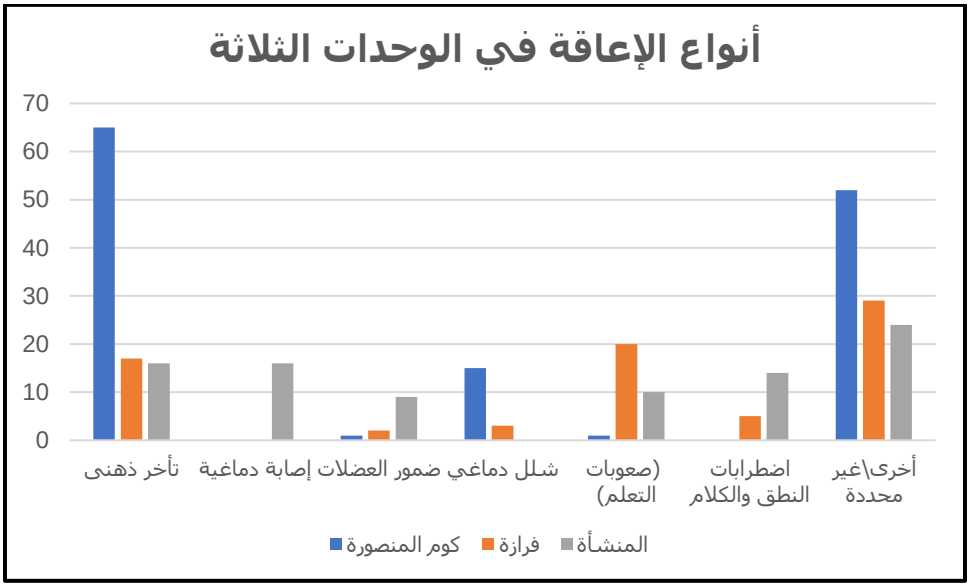
أنواع حالات المستفيدين (المنشأة)



أنواع حالات المستفيدين (فرازة)



أنواع حالات المستفيدين (كوم المنصورة)



نوعيات الحالات في الوحدات الثلاثة

- **يعمل المشروع مع أنواع مختلفة من الإعاقات منها الذهنية و البصرية و السمعية و الحركية و طيف التوحد، و لكن أعداد و نسب أنواع الإعاقة متباينة؛ فمن العددالكلي للأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من الخدمات في الوحدات الثلاثة و الذي يبلغ (451)، تمثل الإعاقة الذهنية و ما يرتبط بها من حالات نسبة (35%)، و تمثل الإعاقة البصرية (10%)، و تمثل الإعاقة السمعية و ما يرتبط بها من حالات (10%) و تمثل الإعاقة الحركية و ما يرتبط بها من حالات (10%) و تمثل إعاقة طيف التوحد (1%) و الإعاقات المتعددة (10%) و الحالات الغير محددة (23%).**
- **هناك احتياج لمراجعة عملية تحديد أنواع الحالات و تحديد أسس سليمة و متفق عليها و موحدة، و ذلك بواسطة المدير الفني لكيان مع المدراء الفنيين للمحافظات و المشرفين الفنيين.**
- **هناك احتياج للوصول بشكل أكبر لإعاقات طيف التوحد و الإعاقات البصرية و السمعية و الحركية.**
- **هناك احتياج للعمل على محاولة تحديد أنواع الإعاقات غير المحددة حيث تمثل عدداً كبيراً نسبياً (105 حالة في المشروع- 23%)**

2.1.3. أنواع الجلسات و الخدمات المقدمة:

تقدم الوحدة أنواعاً مختلفة من الجلسات و الخدمات، تتضمن تنمية قدرات و تنمية مهارات و لغوية و مهارات حسية و تأهيل أكاديمي و تأهيل حركي و تعديل سلوك (إدارة مشاكل سلوكية) و ارشاد أسري و ارشاد للشخص نفسه و إحالة للمراكز و الخدمات المتخصصة، كما تقدم خدمات مثل الجولات الحرة و الأيام الترفيهية و ندوات التوعية و ورش عمل للأمهات و تختلف أعداد و نسب أأنواع الخدمات المختلفة المقدمة، كما تختلف بعض المسميات المستخدمة بين الوحدات المختلفة.

ففي وحدة **المنشأة** كانت أنواع و أعداد الجلسات كما هو موضح في الجدول التالي

نوع الجلسة (بصرف النظر عن نوع الإعاقة)	عدد الجلسات
تنمية مهارات لغوية	**250**
تأهيل اكاديمي / تنمية قدرات	**450**
تعديل سلوك	**38**
إجمالي الجلسات في الوحدة	**738**
زيارات منزلية	**1350**
جولات حرة	14 جولة
يوم ترفيهي	1 يوم
ندوات توعوية	4 ندوات
ورش للامهات	7 ورش

أنواع و أعداد الجلسات في وحدة المنشأة

بينما في وحدة **فرازة** لم يكن هناك حساب لعدد الجلسات من كل نوع

نوع الجلسة (بصرف النظر عن نوع الإعاقة)	عدد الجلسات
لا يوجد تقسيم متبع بالوحدة خاص بتفصيل الجلسات جاري تحسين الوضع	1059
جولات حرة	8
ندوات توعية	1
ايام ترفيهية	1
(الزيارات المنزلية)	879

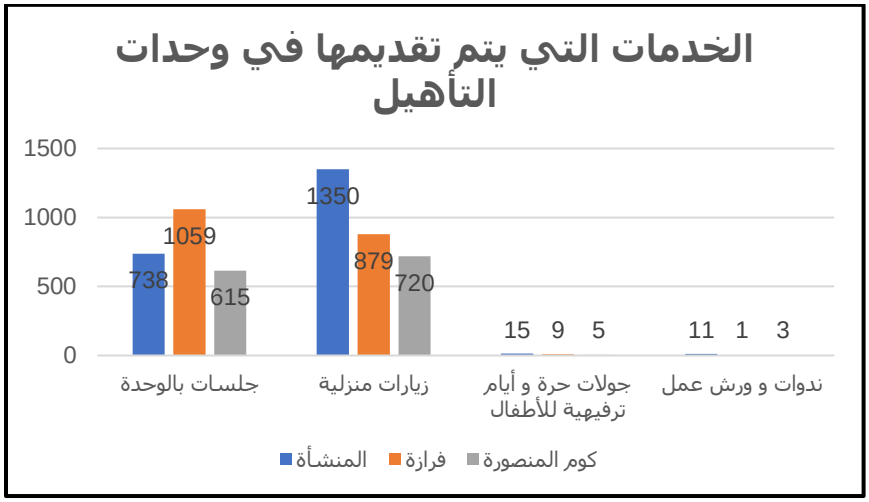
أنواع و أعداد الجلسات في وحدة فرازة

و في وحدة **كوم المنصورة** كذلك لم يكن هناك حساب لعدد الجلسات من كل نوع

نوع الجلسة (بصرف النظر عن نوع الإعاقة)	عدد الجلسات
لا يوجد تقسيم متبع بالوحدة خاص بتفصيل الجلسات جاري تحسين الوضع	(615)

جولات حرة	(5)
ندوات توعية	(3)
(الزيارات المنزلية)	**720**

أنواع و أعداد الجلسات في وحدة كوم المنصورة



أعداد أنواع الخدمات المختلفة المقدمة في الوحدات الثلاث

- **يقدم المشروع أنواع مختلفة من الخدمات و الجلسات، و نسبة الخدمات الجماعية المقدمة للأسر أو للأطفال قليلة جداً مقارنة بالجلسات الفردية و الزيارات المنزلية، و هناك احتياج لزيادة الاهتمام بهذه الخدمات مثل الأيام الترفيهية و الجولات الحرة و ندوات و ورش عمل الأمهات، لتأثيرها الكبير و الواسع على المستفيدين و المجتمع.**
- **هناك احتياج لتحديد و توحيد المسميات المستخدمة لأنواع الجلسات و الخدمات.**
- **هناك احتياج لتجميع أعداد الأنواع المختلفة من الجلسات التي تقدم في الوحدة بكل من فرازة و كوم المنصورة.**
- **لم تذكر جلسات التأهيل الحركي و تنمية المهارات الحسية و الإرشاد الأسري ضمن الجلسات التي تقدم في وحدة المنشأة.**

2.1.4. تقييم الأطفال و حالات الزيارات المنزلية:

يتم تقييم الأطفال باستخدام مجموعة من الأدوات منها: قائمة بورتيدج، استمارات و أدوات تقييم سمعي، حسي (بصري و سمعي)، أكاديمي، مجموعات ضمنية، تقييم الأصوات، مشكلات سلوكية، صعوبات تعلم، .. يتم تحديد العمر التطوري و النسبة التطورية للأطفال تحت سن (6) سنوات، أما الأطفال فوق هذا السن

فلا تحدد لهم نسبة تطورية و لكن يتم تحديد ما يستطيعون القيام به، أما حالات الزيارة المنزلية فيتم معها استخدام قائمة الاحتياجات المرفقة بكتيبات منظمة الصحة العالمية عن التأهيل المرتكز على المجتمع.

2.1.5. وضع خطط التدخل:

يتم وضع خطط التدخل للأطفال الذين سيحصلون على جلسات بالوحدة دائماً (سواء ماقبل أو ما بعد (6) سنوات) بناء على نتائج التقييم، فيتم وضع (25) هدف، بواقع (5) أهداف في كل من المجالات الخمسة لتطور الطفل (الحركي، المعرفي، الاجتماعي، اللغوي، و رعاية الذات)، و في حالة الزيارات المنزلية يتم اختيار الأهداف بناء على التقييم الذي تم بواسطة قائمة الاحتياجات المرفقة بكتيبات منظمة الصحة العالمية عن التأهيل المرتكز على المجتمع، و تغطي الخطة (4) أشهر، تستخدم جميع مسؤولات التأهيل في جميع الوحدات هذه الطريقة بغض النظر عن مستوى تطور و أداء الطفل.

- **تساعد طريقة وضع خطط التدخل بنفس الطريقة دائماً على توحيد طريقة العمل و تسهيل متابعة تطور الطفل و أداء مسؤولات التأهيل.**
- **إلا أن وضع نفس عدد الأهداف دائماً للأطفال مهما اختلفت قدراتهم و مستوى تطورهم يؤدي أحياناً إلي أخذ انطباعاً خاطئاً عن تطور الطفل و أداء مسؤولة التدريب ؛ بالزيادة في الحالات البسيطة و و بالنقص في الحالات الشديدة.**
- **يفضل أن يتم تدريب مسؤولات التدريب على وضع أهداف تتناسب مع مستوى و سرعة تطور الطفل مع الاحتفاظ بكون عدد الأهداف ثابت (5 في كل مجال)، و ذلك عن طريق تقسيم الأهداف لأهداف جزئية في الحالات الصعبة و ربما جمع عدة أهداف في هدف واحد في الحالات البسيطة.**

2.1.6. وضع أهداف الجلسات و تنفيذها:

2.1.6.1. الجلسات داخل وحدة التأهيل المرتكز على المجتمع

يتم اختيار أهداف كل جلسة من أهداف خطة التدخل التي تم وضعها مسبقاً و بترتيب وجودها في القوائم الإرتقائية، تقوم جميع مسؤولات التأهيل في جميع الوحدات بهذا و بنفس الطريقة.

- يسهل اتباع هذه الطريقة المنظمة قيام مسؤولات التأهيل بوضع الأهداف و من ثم تنفيذها إلا أن هذه الطريقة لا تراعي غالباً ربط الأهداف ببعضها و ربط المجالات ببعضها، مما ينعكس على أداء مسؤولات التأهيل للجلسات.
- يتم تنفيذ الجلسات في حجرات خاصة، و تختلف خصائص حجرة تنفيذ الجلسات؛ فهي واسعة و مضاءة جيداً في وحدتي"فرازة و كوم المنصورة بأسيوط"، و لكنها حجرتين صغيرتين متجاورتين بينهما فواصل خشبية و لا يسمحان بحركة الطفل و مسؤولة التأهيل بشكل مناسب في وحدة "المنشأة في سوهاج".
- الأدوات المطلوبة لأداء الجلسات متوفرة في كل الوحدات بشكل مناسب، و يتم استخدامها بواسطة مسؤولات التأهيل بشكل جيد في أغلب الأحوال.
- لا تحضر الأمهات في أغلب الجلسات، و يسود اعتقاد عام بأن حضور الأمهات يسبب تشتتاً للأطفال (صحيح أن مساحة الغرف ربما لا تسمح أحياناً بتواجد الأمهات بشكل مناسب، و لكن عدم

حضورهن يقلل من فهمهن لما يدور في الجلسات و تعلمهن كيف يؤدين أدوارهن مع الأطفال في المنزل).

- تتم كتابة ملاحظات مسؤولة التأهيل عن الجلسة و أداء الطفل في كراسة الطفل و شرح ذلك للأم بعد الجلسة بشكل جيد و منتظم.
- لا تربط المسؤولات بشكل عام بين الأهداف المختلفة داخل نفس المجال و لا بين المجالات المختلفة لتطور الطفل بالشكل المناسب.

❖ أداء مسؤولات التأهيل بشكل عام جيد في وحدتي"فرازة بأسيوط" و "المنشأة في سوهاج"، ، و أقل من المطلوب في وحدة "كوم المنصورة في أسيوط".

❖ **يفضل أن يتم تدريب مسؤولات التدريب على ربط الأهداف في كل مجال و ربط المجالات معاً أثناء إعداد و تنفيذ الجلسات، و اعداد سيناريو الجلسة و التعامل مع المواقف الصعبة أثناء تنفيذ الجلسات.**

❖ **يفضل حضور الأمهات و مشاركتهن في الجلسات كلما أمكن ذلك، لما في ذلك من فوائد للأم و الطفل، و خاصة فيما يرتبط بأداء الأمهات مع الأطفال في المنزل.**

2.1.6.2. الزيارات المنزلية:

يتم اختيار أهداف كل جلسة من أهداف خطة التدخل التي تم وضعها مسبقاً، و تقوم مسؤولة التأهيل بتقديم الدعم اللازم و تنفيذ التدريبات اللازمة تبعاً لاحتياجات الشخص ذي الإعاقة و أسرته، و يتضمن ذلك:

- تقديم دعم نفسي للشخص ذي الاعاقة و الأسرة و رفع الروح المعنوية لهم.
- تقديم التوعية و الإرشاد و التوجيه للشخص و الأسرة.
- العمل على تعديل السلوكيات المشكلة أو الضارة و تعليم سلوكيات مناسبة.
- التدريب على الرعاية الذاتية و الاعتماد على النفس في الأكل و الشرب و الحمام و النظافة الشخصية.
- التدريب على التعرف على مصادر الخطر و تجنبها.
- التدريب على الترتيب و أداء الأعمال المنزلية و التعاون أو المساعدة في أدائها.
- التدريب على المهارات المطلوبة و المناسبة مثل؛ تمرينات عضلات الفم و الوجه و التدريب على النطق و الكلام.
- تنمية المهارات الأكاديمية.
- عمل تمرينات للحركة و تقوية العضلات.
- تدريب الأمهات على ما يمكنهن عمله مع أطفالهن في المنزل.
- التدريب على الخروج من المنزل و التعامل مع البيئة الخارجية.
- ممارسة أوجه الحياة المختلفة.
- العمل مع الإخوان و الأخوات من ذوي الاعاقة إذا كانوا موجودين.

2.1.7. تقييم تقدم الأشخاص ذوي الإعاقة

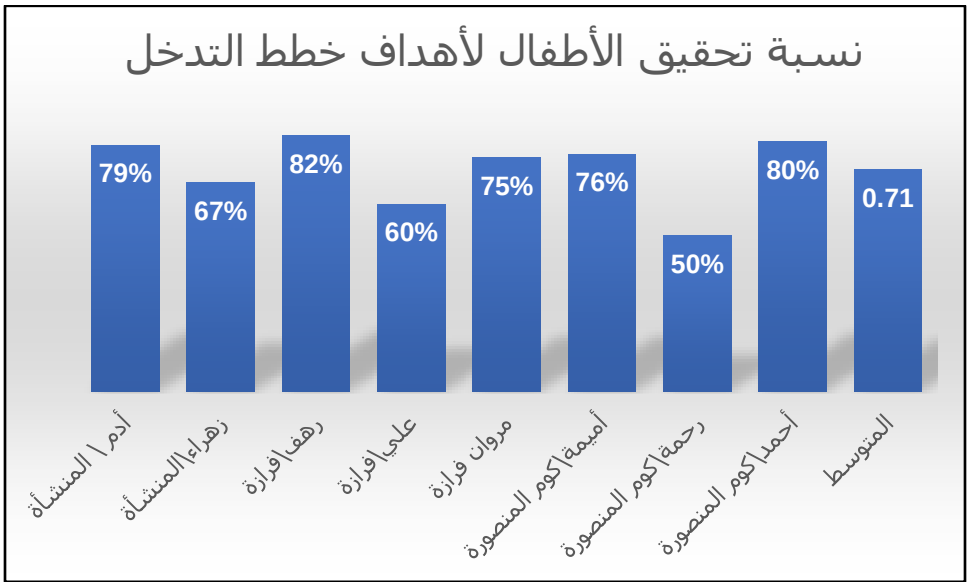
2.1.7.1. تقييم تقدم الأطفال الذين يتلقون جلسات في الوحدة:

يتم تقييم تقدم الأطفال من خلال حساب نسبة تحقيق الأهداف ال (25) الموضوعة في خطة التدخل (كل 4 شهور)، و في حالة الأطفال الذين يتلقون جلسات بورتيدج تتم المتابعة باعادة حساب العمر التطوري و النسبة التطورية (كل 4 شهور)، إلا أن ملفات الحالات لا تتضمن مؤشرات أو تقارير واضحة يمكن من خلالها تحديد مدى تقدم الطفل بسهولة.

- تساعد هذه الطريقة في سهولة عملية وضع الخطة و الأهداف، و تتفق مع طريقة وضع مؤشرات التقدم في الإطار المنطقي للمشروع.
- كما أسلفنا فإن طريقة وضع أهداف الخطة تؤثر أحياناً في عدم دقة قياس تقدم الأطفال، فهي تظهر تقدم الطفل ضعيفاً جداً - أكثر من الواقع - في الحالات الشديدة، و تظهر تقدم الطفل كبيراً جداً - أكثر من الواقع - في الحالات البسيطة.
- أظهر أطفال العينة درجات جيدة من التقدم كما يتضح من الجدول و الشكل التاليين:

الاسم \ الوحدة	نوعية الإعاقة	السن بالسنوات	نسبة تحقيق الأهداف
أدم \ المنشأة	ذهنية	7,5	79%
زهراء\المنشأة	سمعية	11	67%
رهف\فرازة	متلازمة داون\ذهنية	2	82%
علي\فرازة	صعوبات أكاديمية	9	60%
مروان فرازة	صعوبات نطق و كلام	3	75%
أميمة\كوم المنصورة	متعددة	5	76%
رحمة\كوم المنصورة	ذهنية	10	50%
أحمد\كوم المنصورة	متعددة	6	80%
المتوسط			0.71

تقدم الأطفال الذين يحصلون على جلسات تأهيل في الوحدات (عينة من الأطفال)



تقدم الأطفال الذين يحصلون على جلسات تأهيل في الوحدات (عينة من الأطفال)

- **يظهر الأطفال الذين يتلقون جلسات في الوحدات تحسناً ملموساً كمياً و كيفياً.**
- **تراوحت نسبة تحقيق الأهداف بين 50% و 82% بمتوسط 71%، و هذه نسبة جيدة.**
- **يحتاج الأمر لكتابة تقرير مختصر عن تقدم الحالة بصفة شهرية يوضح مدى تقدم الحالة بشكل واضح و يكون مكوناً أساسياً في ملف كل طفل.**

- أكدت جميع أمهات الأطفال في مقابلاتهن بعد ملاحظة الجلسات على أن أطفالهن أظهروا تحسناً نوعياً ملموساً نتيجة لحضور الجلسات في الوحدة.

2.1.7.2. تقييم تقدم تقدم الأشخاص الذين يتلقون زيارات منزلية

يتم تقييم تقدم الأشخاص الذين يتلقون زيارات منزلية من خلال حساب نسبة تحقيق الأهداف التي تم وضعها في خطة التدخل (كل 4 شهور) بناءً على تقييم احتياجات الشخص و الأسرة.

كما أسلفنا فإن طريقة وضع أهداف الخطة تؤثر أحياناً في عدم دقة قياس تقدم الأطفال، فهي تظهر تقدم الطفل ضعيفاً جداً - أكثر من الواقع - في الحالات الشديدة، و تظهر تقدم الطفل كبيراً جداً - أكثر من الواقع - في الحالات البسيطة.

لم يتم أثناء الزيارة الميدانية الإطلاع على ملفات أو تقييمات الأشخاص الذين يتلقون زيارات منزلية، و ما تتضمنه من تقارير عن التقدم.

يفيد رأي الأمهات و مقدمي الرعاية كذلك في تقييم تقدم هؤلاء الأشخاص، وفي هذه المراجعة، أفادت جميع االأمهات و مقدمي الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة اللاتي تمت مقابلتهن (15) - بوضوح - أن أبنائهن و بناتهن قد استفادوا من الزيارات المنزلية، و تحسن الكثير من مهاراتهم و سلوكياتهم.

- **يظهر الأطفال الذين يتلقون جلسات في الوحدات تحسناً ملموساً كيفياً.**
- **هناك احتياج لكتابة تقرير مختصر عن تقدم الحالة بصفة شهرية يوضح مدى تقدم الحالة بشكل واضح و يكون مكوناً أساسياً في ملف كل شخص من ذوي الإعاقة يتلقى زيارات منزلية.**

2.1.8. تقييم الجلسات و أداء مسؤولات التأهيل:

يتم ذلك بواسطة المشرف الفني من خلال: تقييم الإعداد للجلسة، وضع الأهداف و تحقيقها، و وضع الطفل و أداؤه أثناء الجلسة، و أداء مسؤولة التأهيل للأنشطة و قدرتها على الابتكار و التجديد. و يتم كتابة تقرير بالملاحظات و التوصيات و الاحتياجات و طرق تلبيتها.

- يتم ذلك في الأغلب بدون استخدام استمارة موحدة.

- **هناك احتياج لعمل استمارة بسيطة و محددة و موحدة لتقييم أداء مسؤولات التأهيل، يتم تطبيقها ربع سنوياً خاصة لتقييم للمسؤولات الجدد، و يمكن أن يصبح التطبيق نصف سنوياً بعد ذلك.**
- **أظهرت غالبية مسؤولات التأهيل مستوى جيد إلى جيد جداً من الكفاءة في تقديم الجلسات و كان متوسط درجة الجودة باستخدام أداة التقييم المستخدمة في هذه المراجعة هي (78,1 %) لمسؤولات وحدة "المنشأة بسوهاج"، (77,9%) لمسؤولات وحدة "فرازة بأسيوط"، و إن كان هذا المتوسط أقل في وحدة "كوم المنصورة بأسيوط" إذ كان (61.7%) فقط.**

2.1.9. تسجيل أنشطة الوحدة: (تمت مراجعة مثال؛ شيت التسجيل الإلكتروني الخاص بوحدة المنشأة)

يتم تسجيل ما يخص الوحدة الكترونياً (كان يتم التسجيل ورقياً في السابق) و ذلك في "شيت إكسل" متكامل خاص بكل وحدة، يتضمن الشيت (4) شيتات فرعية:

(أ) التقارير الشهرية للوحدة و يتضمن: إجمالي المستفيدين شهرياً و خلال العام، و عدد الأطفال ذوي الإعاقة (أقل من 14 سنة) المستفيدين بجلسات داخل الوحدة (المخطط للعام و الجدد خلال الشهر و المنقطعين خلال الشهر و المستفيدين شهرياً الإجمالي و من الذكور و الإناث، و عدد الأشخاص الذين تم رصدهم بالكامل و خلال الشهر، و عدد الأشخاص الذين يتلقون زيارات منزلية المخطط له و الجدد و المنقطعين خلال الشهر و المستفيدين شهرياً من الأطفال و البالغين من

الذكور و الإناث و الإجمالي، و أعداد جلسات التأهيل داخل الوحدة (دون تحديد نوع الجلسة) ، و أعداد الزيارات المنزلية (مع تحديد الهدف منها بشكل عام .. ارشاد للأسر و ارشاد للشخص نفسه و جلسات تأهيل و خدمات اجتماعية) و الاجمالي، و المساعدات الاجتماعية (مع تحديد أنواعها المختلفة)، و الخدمات النفسية و الأنشطة المجتمعية بأنواعها.

(ب)متابعة الإحالة و يتضمن: بيانات الشخص و التشخيص و سبب الإحالة و الجهة المحول إليها و بياناتها و تاريخ الإحالة و تاريخ اتمام الخدمة و النتائج.

(ت) تقدير احتياجات الشخص و الأسر و يتضمن: كود المسؤولة عن رصد الاحتياجات و بيانات الشخص و الخدمات التأهيلية التي يحتاج لها (زيارات منزلية، ارشادات أسرية، جلسات تأهيلية، تقييمات نفسية) و الخدمات الإجتماعية التي يحتاج لها (17 نوع من الخدمات؛ طبية و اقتصادية و منزلية ..)، و الإحالة.

(ث)مجمع استمارات الرصد بتفاصيل كاملة عن الشخص و الأسرة

(ج) قاعدة بيانات المستفيدين و يتضمن: بيانات الشخص و العائل أو القائم بالرعاية و نوع الإعاقة (14 نوع تحتاج للمراجعة) و الخدمات التأهيلية داخل و خارج الوحدة من جلسات (4) و زيارات منزلية (6) و تقييمات (7)، و خدمات اجتماعية (17 نوع من الخدمات؛ طبية و اقتصادية و منزلية ..).

- **قواعد البيانات للوحدات ممتازة و شاملة و مستخدمة.**
- **ينقص القواعد بعض النقاط لتحسين كفاءتها في الجوانب الفنية و أهمها: إضافة نوع الجلسات الفنية بقدر أكبر من التفصيل (مثل الخدمات الاجتماعية مثلاً)، مراجعة أنواع الإعاقة المستخدمة (و التي تحتاج للتعديل و الإضافة و الحذف) و إضافة وصف أو تحديد للتقدم الذي يحرزه الشخص ذو الإعاقة.**

2.1.10. الإتاحة الفيزيقية:

بعض الوحدات غير متاحة فيزيقياً على الإطلاق؛ فهي في الدور الأول فوق الأرضي مثلاً، و السلالم ضيقة و ليس لها درابزين، و صعب استخدامها حتى للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية الذين يستطيعون الوقوف و المشي، و الوحدات التي في الدور الأرضي تكون أحياناً مرتفعة عن سطح الأرض و بها سلم أيضاً بارتفاع بعض الدرجات، و ليس بها منحدر،كما أن دورات المياه في الأغلب ليست متاحة.

- المستفيدون الذين يحضرون للوحدة في الأغلب من الأطفال و من غير ذوي الإعاقة الحركية، مما يقلل من تأثير عدم الإتاحة الفيزيقية.
- كما أن الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية الذين لا يستطيعون صعود السلالم أو لا تستطيع أمهاتهن حملهم و طلوع السلالم يتم توفير الخدمات لهم من خلال الزيارات المنزلية.

- **هناك احتياج لمراجعة الاتاحة الفيزيقية لكافة الوحدات، و دراسة حالة كل وحدة على حدة لتقدير حجم مشكلة الاتاحة و التحديات الناتجة عنها و امكانيات التصدي لها بحلول ذكية.**

2.1.11. إجراءات الأمن و السلامة و الحماية و الشكاوى:

يتم مراعاة أمن و سلامة و حماية الطفل بشكل عام، إذ يوجد ميثاق أخلاقي و وسياسة للحماية يطّلع عليهما العاملون و يوقعون عليهما، و يعملون على تطبيقهما ولو بشكل غير كامل، و لكن لا يوجد صندوق للشكاوى، و يعتمد نظام العمل على أن من لديه شكوى سيتقدم به للجمعية المحلية المنفذة، و لكن اجراءات الأمن و السلامة و الحماية و الشكاوى تحتاج إلى مزيد من الجهد المنظم لتطبيقها.

- **هناك احتياج للنظر في كيفية عمل خطوة للأمام في اتجاه تطبيق أفضل لسياسة الحماية و تفعيل أقوى لنظام الشكاوى و مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة و أسرهم في الإدارة المحلية لوحدات المشروع.**

2.2. فاعلية الخدمات الفنية:

2.2.1. أعداد المستفيدين:

حقق المشروع درجة عالية من الفاعلية من حيث عدد المستفيدين، إذ تعمل الوحدات الثلاثة على تقديم خدماتها ل (451) شخص من ذوي الإعاقة من بداية المشروع و حتى تاريخ هذه المراجعة الفنية، و لقد قدم المشروع خدماته المختلفة بالفعل لعدد (4069) مستفيد، و هو ما يقترب جداً من العدد المستهدف حتى نهاية المشروع و هو (4850).

2.2.2. التحسن في حالات المستفيدين:

حقق المشروع درجة جيدة من الفاعلية من حيث استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من خدمات المشروع و اظهارهم تحسناً في مهاراتهم و سلوكياتهم و جوانب متعددة من حياتهم، نتيجة لتلقيهم خدمات مختلفة من خلال وحدات التأهيل.

2.2.2.1. المستفيدون من الجلسات المنفذة في وحدات التأهيل المرتكز على المجتمع:

في حدود المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال الحالات التي تمت دراستها كعينة (8) هناك تحسن جيد كمي و كيفي في تحقيق أهداف الجلسات المقدمة في المركز استناداً إلى قياسات مدى تحقيق أهداف البرامج و الجلسات المقدمة لهم و إلى ما أكدته الأمهات في اللقاءات معهم. إذ تراوحت نسبة تحقيق الأهداف بين 50% و 82% بمتوسط 71%، و هذه نسبة جيدة، كما أكدت جميع أمهات الأطفال في مقابلاتهن على أن أطفالهن أظهروا تحسناً نوعياً ملموساً نتيجة لحضور الجلسات في الوحدة.

2.2.2.2. المستفيدون من الزيارات المنزلية:

- أفادت جميع االأمهات و مقدمي الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة اللاتي تمت مقابلتهن (15) ؛ (5) من "المنشأة" في سوهاج، و (5) من "فرازة" في أسيوط، و (5) من "كوم المنصورة" أن أبنائهن و بناتهن قد استفادوا من الزيارات المنزلية، و كان أهم ما اكتسبوه يتضمن تحسن الحالة النفسية، و تحسن بعض السلوكيات و المهارات و الأداءات مثل الفهم و التركيز و الأداء المدرسي و النطق و و الكلام و الرعاية الذاتية و الاعتماد على النفس و المشاركة و الاستجابة للأخرين و التعامل معهم، و الخروج خارج المنزل ..

- و أفدن أنهن قد تعلمن من ملاحظة مسؤولات التدريب أثناء الزيارات كيف يقمن بتدريب أبنائهن و كيف يساعدنهم في تنمية مهارتهم الحركية و اللغوية و تحسين سلوكياتهم و تعاملهم مع الأخرين.
- كما أفدن أنهن استفدن شخصياً بهذه الزيارات من حيث تحسن طريقة تعاملهن مع الأشخاص ذوي الاعاقة و رعايتهن، و تحسن فهمهن و تقبلهن للحالة و الاحساس بالأمل و التفاؤل و الدعم.
- لم تشر أي من الأمهات إلى أي شييء يضايقهن أثناء الزيارات على الاطلاق.

2.2.2.3. المستفيدون من الأنشطة الدامجة و التوعوية:

- أفادت (13) من االأمهات و مقدمي الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة (4) من المنشأة في سوهاج، و (5) من "فرازة" في أسيوط، و (4) من "كوم المنصورة" أن أطفالهن المندمجين في مدارس أو حضانات قد استفادوا من المشاركة في الأنشطة الدامجة و التوعوية، و تعلموا أشياء كثيرة عن المجتمع المحيط بهم.
- كما أن الأطفال منتظمون في جلسات (تعديل سلوك و تنمية مهارات و تنمية لغة و أكاديمي) و يشاركون في الآنشطة الدامجة، مما ساعد في تنمية قدراتهم المختلفة و ساعدهم في الاندماج.
- و أشرن أنهن و أطفالهن يسعدون بالرحلات و الجولات الحرة، كما أنهن يستفدن من الندوات التوعوية.

2.2.2.4. الأمهات

- أفادت جميع الأمهات اللاتي تمت مقابلتهن (8 أمهات لأطفال يحصلون على جلسات في الوحدة و 15 أمهات لأطفال يحصلون على زيارات منزلية و 13 أمهات لأطفال يستفيدون من الأنشطة الدامجة) أنهن استفدن من الخدمات المقدمة من جوانب؛ الاحساس بتقدم الأطفال و بالتفاؤل و بالثقة في النفس و بأن هناك من يدعمهن و يهتم بهن و بأطفالهن، و أنهن اكتسبن مهارات التعامل مع الأطفال بشكل أفضل و مساعدتهم في أداء الواجبات المنزلية و تدريبهم على الأداءات و السلوكيات المطلوبة.

ثانياً: تقارير الوحدات محل المراجعة

(أ) وحدة المنشأة في سوهاج

سير العمل و فرق العمل

فرق العمل:

تكوين الفريق:

يتكون فريق العمل من: "أحمد عرفه" مدير المكتب، "آية صلاح" مدير فني للمكتب (تشرف على 5 وحدات)، و "سناء خليفة" منسق المشروع (تشرف على 5 وحدات في المحافظة) ، و "فاطمة عبد العزيز" مشرف فني (لعدد من الوحدات)، و "محمود فرغل" منسق التأهيل بالمكتب (لعدد من الوحدات) ، و (3) مسؤولات تأهيل "ريم ، آيات" (في وحدة المنشأة)

وظائف الفريق: (مرفق التوصيف الوظيفي لفرق العمل)

المستوى الفني للفريق:

المستوى الفني **للمدير الفني للمكتب** "آية صلاح" عالي جداً ، من خلال الحصول على الكثير من التدريب و تكوين خبرات قوية من خلال العمل في كيان و خارجها و اتقان أحد التخصصات المهمة في مجال التأهيل (التكامل الحسي)، و المستوى الفني يناسب طبيعة المهام الوظيفية.

المستوى الفني **للمشرف الفني** "فاطمة عبد العزيز" جيد جداً، من خلال مؤهل مناسب (ليسانس علم نفس) و الحصول على الكثير من التدريب (بورتيدج، تعديل سلوك، اختبار فاينلاند، اختبار الذكاء، التكامل الحسي و تكوين خبرات قوية من خلال العمل في كيان و خارجها، و المستوى الفني يناسب طبيعة المهام الوظيفية.

المستوى الفني **لمنسق التأهيل بالمكتب** جيد، و له خبرات سابقة طويلة.

المستوى الفني **لمسؤولات التأهيل** جيد، و قد حصلن على (35) يوم تدريب مقسمة على عدة مراحل، شملت التدريبات (التأهيل المرتكز على المجتمع، تأهيل الاعاقات المختلفة؛ حركية و ذهنية و بصرية و سمعية و صعوبات تعلم، إدارة الجلسات، الزيارات المنزلية، حماية الطفل ..)، كما يحصلن على تدريبات تنشيطية و تدريبات على رأس العمل، و هو يناسب طبيعة المهام الوظيفية.

أسلوب و سير العمل:

كفاءة الخدمات الفنية:

العمل مع الفئات العمرية المختلفة من الجنسين:

تخدم وحدة المنشأة 63 (53%) من الذكور و 56 (47%) من الإناث، و 58 (49%) من الأطفال و 61 (51%) من البالغين.

(بناءً على قاعدة بيانات المشروع)

العمل مع أنواع الإعاقات المختلفة:

تتضمن أنواع الإعاقات: تأخر ذهني، تأخر لغوي، صعوبات تعلم (قد تكون هناك صعوبات في التشخيص المعطى لبعض الحالات)، توحد (قد تكون هناك صعوبات في التشخيص المعطى لبعض الحالات)، تشتت انتباه و فرط حركة، اعاقات سمعية، اعاقات حركية، ..

م	نوع الاعاقة	عدد المستفيدين	أنواع الجلسات المقدمة
1	تأخر ذهنى	16	تنمية قدرات / تنمية قدرات لغوية /إدارة مشكلات سلوكية
2	متلازمة داون	2	
3	عيوب التمثيل الغذائي	0	لا توجد
4	إصابة دماغية	16	تنمية قدرات /تنمية قدرات لغوية
5	ضمور العضلات	9	تنمية قدرات /تاهيل حركي
6	اضطراب طيف التوحد	2	تنمية قدرات /تنمية مهارات لغوية / تنمية مهارات حسية
7	اضطراب التعلم المحدد (صعوبات)	10	تاهيل أكاديمي
8	اضطرابات النطق والكلام	14	تنمية مهارات لغوية
9	اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه	5	تنمية مهارات لغوية / تنمية قدرات / تنمية مهارات حسية
10	متلازمة إرلن	1	تنمية قدرات
11	إعاقة سمعية	11	تاهيل سمعي
12	إعاقة بصرية	10	ارشاد أسري
13	إعاقات متعددة	13	تنمية قدرات / تنمية قدرات لغوية /إدارة مشكلات سلوكية
14	أخرى	24	تنمية قدرات / تنمية قدرات لغوية /إدارة مشكلات سلوكية
	اجمالي	120	

نوع الجلسة (بصرف النظر عن نوع الإعاقة)	عدد الجلسات
تنمية مهارات لغوية	**250**
تأهيل اكاديمي / تنمية قدرات	**450**
تعديل سلوك	**38**
الإجمالي	**738**

نوع الخدمة\النشاط (بصرف النظر عن نوع الإعاقة)	عدد الجلسات
جلسات	**738**
زيارات	**1350**
جولات حرة	14 جولة
يوم ترفيهي	1 يوم

ندوات توعوية	4 ندوات
ورش للامهات	7 ورش

تقييم الأطفال و حالات الزيارات المنزلية:

يتم تقييم الأطفال باستخدام مجموعة من الأدوات منها: قائمة بورتيدج، استمارات و أدوات تقييم سمعي، حسي (بصري و سمعي)، أكاديمي، مجموعات ضمنية، تقييم الأصوات، مشكلات سلوكية، صعوبات تعلم، .. يتم تحديد العمر التطوري و النسبة التطورية للأطفال تحت سن (6) سنوات، أما الأطفال فوق هذا السن فلا تحدد لهم نسبة تطورية و لكن يتم تحديد ما يستطيعون القيام به، أما حالات الزيارة المنزلية فيتم معها استخدام قائمة الاحتياجات المرفقة بكتيبات منظمة الصحة العالمية عن التأهيل المرتكز على المجتمع.

وضع خطط التدخل:

يتم وضع خطط التدخل للأطفال الذين سيحصلون على جلسات بالوحدة (سواء ماقبل أو ما بعد (6) سنوات) بناء على نتائج التقييم، فيتم وضع (25) هدف، بواقع (5) أهداف في كل من المجالات الخمسة لتطور الطفل (الحركي، المعرفي، الاجتماعي، اللغوي، و رعاية الذات)، و في حالة الزيارات المنزلية يتم اختيار الأهداف بناء على التقييم الذي تم بواسطة قائمة الاحتياجات المرفقة بكتيبات منظمة الصحة العالمية عن التأهيل المرتكز على المجتمع، و تغطي الخطة (4) أشهر.

وضع أهداف الجلسات و تنفيذها:

يتم اختيار أهداف كل جلسة من أهداف خطة التدخل التي تم وضعها مسبقاً، و يتم تنفيذ الجلسات في حجرتين صغيرتين متجاورتين بينهما فواصل خشبية (الحجرتان يفضل تغيير مكانهما إن أمكن حيث لا يسمحان بحركة الطفل و مسؤولة التأهيل بشكل مناسب)، الأدوات المطلوبة لأداء الجلسات متوفرة بشكل مناسب، الجلستان اللتان تمت ملاحظتهما تمتا و الأطفال جالسين في أماكنهم على الكرسي و أمامهما المنضدة (بدون أن يتحركا في الغرفة)، و لم تحضر الأمهات في الجلسات، و يسود اعتقاد عام أن حضور الأمهات يسبب تشتتاً للأطفال (الحقيقة أن مساحة الغرف ربما لا تسمح بتواجد الأمهات بشكل مناسب، و لكن هذا يقلل من فهم الأمهات لما يدور في الجلسات و تعلمهن كيف يؤدين أدوارهن مع الأطفال في المنزل)، تتم كتابة ملاحظات مسؤولة التأهيل عن الجلسة و أداء الطفل في كراسة الطفل و شرح ذلك للأم بعد الجلسة بشكل جيد و منتظم، كان أداء مسؤولات التأهيل بشكل عام جيد و لكنهما لا يربطان بين الأهداف المختلفة داخل نفس المجال و لا بين المجالات الختلفة بالشكل المناسب.

تقييم تقدم الأطفال:

يتم من خلال حساب نسبة تحقيق الأهداف ال (25) الموضوعة في خطة التدخل (كل 4 شهور)، و في حالة الأطفال الذين يتلقون جلسات بورتيدج تتم المتابعة باعادة حساب العمر التطوري و النسبة التطورية (كل 4 شهور).

تقييم الجلسات و أداء مسؤولات التأهيل:

يتم ذلك من خلال: تقييم الإعداد للجلسة، وضع الأهداف و تحقيقها، و وضع الطفل و أداؤه أثناء الجلسة، و أداء مسؤولة التأهيل للأنشطة و قدرتها على الابتكار و التجديد. و يتم كتابة تقرير بالملاحظات و التوصيات و الاحتياجات و طرق تلبيتها.

تم تقييم الجلسات في هذه المراجعة باستخدام استمارة صممت لهذا الغرض و كانت النسبة المئوية المتوسطة هي (78,1%) و هي نسبة جيدة و تشير درجات الأداءات المختلفة على استمارة التقييم لاحتياج مسؤولات التأهيل و ظروف تنفيذ الجلسات لبعض التطوير.

تسجيل أنشطة الوحدة:

يتم تسجيل ما يخص الوحدة الكترونياً (كان يتم التسجيل ورقياً في السابق) ، كل مستفيد له ملف الكتروني خاص به يشمل استمارة الاحتياجات و الأنشطة المقدمة له، كما يتم تسجيل حالات الاحالة الكترونياً.

الإتاحة الفيزيقية:

الوحدة غير متاحة فيزيقياً؛ فهي في الدور الأول فوق الأرضي، و السلم ضيق و ليس له درابزين، و صعب استخدامه، و من ثم فلا يحتاج الأمر لمزيد من تقييم سبل الاتاحة في الوحدة.

إجراءات الأمن و السلامة و الحماية و الشكاوى:

يتم مراعاة أمن و سلامة و حماية الطفل بشكل عام، إذ يوجد ميثاق أخلاقي و وسياسة للحماية يطّلع عليهما العاملون و يوقعون عليهما، و يعملون على تطبيقهما ولو بشكل غير كامل، و لكن لا يوجد صندوق للشكاوى، و يعتمد نظام العمل على أن من لديه شكوى سيتقدم به للجمعية، و لكن اجراءات الأمن و السلامة و الحماية و الشكاوى تحتاج إلى مزيد من الجهد المنظم لتطبيقها.

الزيارات المنزلية \ الأمهات (القائم بالرعاية)

الأمهات من سوهاج: (5) أمهات (هدى، منى،فاطمة الزهراء، بخيتة) و أخت واحدة (إيمان) ، و هن يقمن برعاية عمرو عبده (اعاقة حركية)، ابتسام (اعاقة سمعية كلامية)، رايدا (اعاقة حركية تستخدم كرسي متحرك)، محمد (اعاقة حركية مع صعوبة في المشي و استخدام السلالم) ، و هيام (اعاقة ذهنية مع احتمال مرض عقلي).

الأسئلة	الإجابات
معرفة الأم بالصعوبات التي تؤثر على الطفل	الجميع يعرفن جيداً حالات الأشخاص ذوي الاعاقة و الصعوبات التي تواجههم بشكل جيد.
معرفة الأم بمدة الحصول على الزيارات المنزلية	الجميع يعرفن المدة التي يحصلن خلالها على زيارات منزلية.
سبب الحصول على زيارة منزلية و عدم الذهاب إلى الوحدة	كانت أهم الأسباب هي صعوبة الوصول بسبب الاعاقة الحركية (3)، و رفض الشخص ذو الاعاقة بسبب احساسه بالحرج بسبب الاعاقة (1)، و شدة الاعاقة الذهنية و صعوبة السيطرة على الشخص ذي الاعاقة (1).
عدد مرات الزيارة المنزلية فى الشهر و ثبات مواعيدها و مدتها	تنفذ جميع الزيارات المنزلية مرتين شهرياً في مواعيد ثابتة و لمدة نحو 45 دقيقة.
ما تقوم به المدربة أثناء الزيارة	تضمن ما تقوم به المدربة تقديم دعم نفسي للشخص ذي الاعاقة و الأسرة، عمل تعديل سلوك و تعليم سلوكيات و مهارات مناسبة، تدريب

	على الكلام، بعض تمرينات للحركة و لتقوية العضلات، و تدريب الأمهات على ما يمكنهن عمله، و تعمل مع الإخوان و الأخوات من ذوي الاعاقة إذا كانوا موجودين.
ما تقوم به الأم أثناء الزيارة	تساعد الأمهات المدربات أثناء الجلسة و يلاحظن ما تقوم به المدربات ليتعلمن منهن.
ما تقوم به الأم في الأيام التي لا تحدث بها الزيارة	يتعاملن مع الأشخاص ذوي الاعاقة بأساليب مناسبة، و ينفذن التمرينات الحركية و التدريبات على الكلام.
استفادة الطفل\الشخص من الزيارات المنزلية	تحسن الحالة النفسية، و تحسن بعض السلوكيات و المهارات و الأداءات.
استفادة الأم من الزيارة المنزلية	تحسن طريقة تعاملهن مع الأشخاص ذوي الاعاقة، و تحسن تقبلهن للحالة و الاحساس بالأمل و التفاؤل و أن هناك من يدعمهن.
ما يضايق الأم في الزيارة المنزلية؟	لم تشر أي من الأمهات إلى أي شيء يضايقهن أثناء الزيارات على الاطلاق.

الدمج و الأنشطة الدامجة \ الأمهات (القائم بالرعاية)

الأمهات من سوهاج: (4) أمهات (وردة، هناء، فايزة، و منال)، و هن يقمن برعاية عصام (مشاكل سلوكية)، محمد (شلل دماغي)، الزهراء و هناء (اعاقة سمعية مزروعي قوقعة)، و شهد و شاهنده (اعاقة سمعية و يستخدمن سماعات)

الأسئلة	الإجابات
معرفة الأم بالصعوبات التي تؤثر على الطفل	الجميع يعرفن جيداً حالات الأشخاص ذوي الاعاقة و الصعوبات التي تواجههم بشكل جيد.
مكان دمج الطفل و السنة الدراسية إن أمكن	الأطفال في سن المدرسة مندمجين في مدارس ابتدائية (عصام و زهراء و هناء و شهد) و شاهنده مندمجة في معهد الخطوط، فيما عدا محمد وهو أصغر من سنة المدرسة و غير مندمج في حضانة بسبب شدة اعاقته.
كيف تمكنت الأسرة من دمج الطفل	جميع الأطفال تم دمجهم في المدارس بالاجراءات المتبعة و بدون صعوبات (تعليم عادي و نظام الدمج)
الصعوبات التي واجهت دمج الطفل	الأطفال مندمجين في الدراسة و لكن مستوى التعليم بشكل عام ضعيف.
كيف ساعدت وحدة التأهيل المرتكز على المجتمع في عملية دمج الطفل	لم تساعد الوحدة في عملية الدمج في المدارس.
الأنشطة اللي قامت بها الوحدة لمساعدة ادماج الطفل (أنشطة دامجة .. جلسات تنمية مهارات و قبل أكاديمي .. رحلات .. فعاليات في المجتمع ..) حالة الطفل في مكان الدمج في الوقت الحالي	الأطفال المندمجين منتظمون في جلسات (تعديل سلوك و تنمية مهارات و تنمية لغة و أكاديمي) و يشاركون في الآنشطة الدامجة.
الصعوبات التي تواجه الطفل في مكان الدمج في الوقت الحالي	لم تشكو الأمهات من أي مشكل حالياً و أفدن أن المشاكل ربما كانت موجودة في البداية و قلت كثيراً مع الوقت.
مساعدة وحدة التأهيل المرتكز على المجتمع في نجاح الطفل في مكان الدمج في الوقت الحالي	الوحدة تساعد من خلال الجلسات و الأنشطة الدامجة و ليس من خلال أنشطة في المدارس.

المشاركة في (أنشطة دامجة .. جلسات تنمية مهارات و قبل أكاديمي .. رحلات .. فعاليات في المجتمع .. فعاليات في المدارس و الحضانات .. ..)	شاركت الأمهات و الأطفال في جولات حرة و حفلات و رحلات دامجة.

(ب) وحدة فرازة في أسيوط

سير العمل و فرق العمل

فرق العمل:

تكوين الفريق:

يتكون فريق العمل من: "سيد عبد اللطيف" مدير مكتب منفلوط، و "هدى أبو اليزيد" مدير فني المكتب، (تشرف على 15 وحدة في أسيوط)، و "آيات على" منسق المشروع (تشرف على 6 وحدات في أسيوط)، و "سناء خليفة" منسق التأهيل بالمكتب، و "مصطفى صابر" مشرف فني للوحدات (على عدد من الوحدات) ، و (3) مسؤولات تأهيل "سعاد ، ياسمين ، فرح" (في كل وحدة فرازة)

وظائف الفريق: (مرفق التوصيف الوظيفي للفرق الفنية)

المستوى الفني للفريق:

المستوى الفني **للمدير الفني للمكتب** "هدى" ممتاز ، من خلال الحصول على الكثير من التدريب و تكوين خبرات قوية من خلال العمل في كيان و خارجها و اتقان العديد من التخصصات المهمة في مجال التأهيل)، و المستوى يناسب طبيعة المهام الوظيفية.

المستوى الفني **للمشرف الفني** "مصطفى صابر" جيد جداً، من خلال مؤهل مناسب ، و الحصول على الكثير من التدريب (بورتيدج، تعديل سلوك، اختبار فاينلاند، اختبار الذكاء، التكامل الحسي و تكوين خبرات قوية من خلال العمل في كيان و خارجها، و هو يناسب طبيعة المهام الوظيفية.

المستوى الفني **لمنسق التأهيل بالمكتب** "سناء" جيد جداً، و حصلت على العديد من التدريبات و لها خبرة طويلة داخل و خارج كيان، و المستوى يناسب طبيعة المهام الوظيفية.

المستوى الفني **لمسؤولات التأهيل** جيد، و قد حصلن على (35) يوم تدريب مقسمة علىعدة مراحل، شملت التدريبات (التأهيل المرتكز على المجتمع، تأهيل الاعاقات المختلفة؛ حركية و ذهنية و بصرية و سمعية و صعوبات تعلم، إدارة الجلسات، الزيارات المنزلية، حماية الطفل ..)، كما يحصلن على تدريبات تنشيطية و تدريبات على رأس العمل، و المستوى يناسب طبيعة المهام الوظيفية.

أسلوب و سير العمل:

كفاءة العمل الفني:

العمل مع الفئات العمرية المختلفة من الجنسين:

تخدم وحدة فرازة 72 (55%) من الذكور و 58 (45%) من الإناث، و 39 ((30%) من الأطفال و 91 (70%) من البالغين.

(بناءً على قاعدة بيانات المشروع)

العمل مع أنواع الإعاقات:

تتضمن أنواع الإعاقات: تأخر ذهني، تأخر لغوي، صعوبات تعلم (قد تكون هناك صعوبات في التشخيص المعطى لبعض الحالات)، توحد (قد تكون هناك صعوبات في التشخيص المعطى لبعض الحالات)، تشتت انتباه و فرط حركة، اعاقات سمعية، اعاقات حركية، ..

أنواع الجلسات المقدمة و نوعية حالات المستفيدين:

تقدم الوحدة أنواعاً مختلفة من الجلسات و الخدمات، و قد قدمت بالفعل (1059) جلسة، في الوحدة و (879) زيارة منزلية، تقدم الوحدة جلسات التدخل ل (132) من الأشخاص ذوي الإعاقة (120 حال منتظمة شهرياً)، كما قدمت جولات حرة و ندوات للتوعية و أيام ترفيهية.

نوع الإعاقة	عدد المستفيدين	أنواع الجلسات المقدمة
تأخر ذهني	17	جلسات تنمية القدرات جلسات تنمية مهارات لغوية تنمية المهارات الحسية إدارة المشكلات السلوكية إرشاد للأسر
متلازمة داون	5	
اضطراب التوحد	2	
اضطراب فرط الحركة ونقص الإنتباه	10	
شلل دماغي	3	جلسات تأهيل حركي جلسات تنمية القدرات جلسات تنمية المهارات اللغوية جلسات تنمية المهارات الحسية إرشاد أسري
ضمور في العضلات	2	
اضطراب التعلم المحدد	20	جلسات تأهيل أكاديمي جلسات تنمية مهارات لغوية إدارة المشكلات السلوكية إرشاد للأسر
اضطرابات النطق والكلام	5	جلسات تصحيح اللدغات إدارة المشكلات السلوكية إرشاد للأسر الإحالة للمراكز المتخصصة
إعاقة سمعية	7	جلسات تأهيل سمعي إدارة المشكلات السلوكية

		إرشاد للأسر الإحالة للمراكز المتخصصة
إعاقة بصرية	17	الإحالة للمراكز المتخصصة (كيان) ارشاد أسري ارشاد للشخص نفسه
إعاقات متعددة	15	
أشخاص غير محدد إعاقتهم	29	

نوع الجلسة (بصرف النظر عن نوع الإعاقة)	عدد الجلسات
لا يوجد تقسيم متبع بالوحدة خاص بتفصيل الجلسات جاري تحسين الوضع	1059

نوع الخدمة\النشاط	عدد الجلسات
جولات حرة	8 (37مستفيد)
ندوات توعية	1 (المستفيدين 34)
ايام ترفيهية	1 (المستفيدين 40 من ذوي الإعاقة / 4 أسر / 4 أخوة).
(الزيارات المنزلية)	879
المساعدات الإجتماعية	1 مستفيد

تقييم الأطفال و حالات الزيارات المنزلية:

يتم تقييم الأطفال باستخدام مجموعة من الأدوات منها: قائمة بورتيدج، استمارات و أدوات تقييم سمعي، حسي (بصري و سمعي)، أكاديمي، مجموعات ضمنية، تقييم الأصوات، مشكلات سلوكية، صعوبات تعلم، .. يتم تحديد العمر التطوري و النسبة التطورية للأطفال تحت سن (6) سنوات، أما الأطفال فوق هذا السن فلا تحدد لهم نسبة تطورية و لكن يتم تحديد ما يستطيعون القيام به، أما حالات الزيارة المنزلية فيتم معها استخدام قائمة الاحتياجات المرفقة بكتيبات منظمة الصحة العالمية عن التأهيل المرتكز على المجتمع.

وضع خطط التدخل:

يتم وضع خطط التدخل للأطفال الذين سيحصلون على جلسات بالوحدة (سواء ماقبل أو ما بعد (6) سنوات) بناء على نتائج التقييم، فيتم وضع (25) هدف، بواقع (5) أهداف في كل من المجالات الخمسة لتطور الطفل (الحركي، المعرفي، الاجتماعي، اللغوي، و رعاية الذات)، و في حالة الزيارات المنزلية يتم اختيار الأهداف بناء على التقييم الذي تم بواسطة قائمة الاحتياجات المرفقة بكتيبات منظمة الصحة العالمية عن التأهيل المرتكز على المجتمع، و تغطي الخطة (4) أشهر.

وضع أهداف الجلسات و تنفيذها:

يتم اختيار أهداف كل جلسة من أهداف خطة التدخل التي تم وضعها مسبقاً، و يتم تنفيذ الجلسات في حجرة واسعة و مضاءة جيداُ و ذات تهوية جيدة و تسمح بحركة الطفل و مسؤولة التأهيل بشكل مناسب، الأدوات المطلوبة لأداء الجلسات متوفرة بشكل مناسب، الجلسات الت تمت ملاحظتها كان الأطفال يجلسون على الكرسي و أمامهما المنضدة بعض الوقت و يتحركون بعض الوقت، حضرت إحدى الأمهات في الجلسة حيث كانت الطفلة صغيرة و تحتاج لوجود الأم، و حضرت أم أخرى جزء من الجلسة للمساعدة في التحكم في الطفل و حركته بعدما خرج عن السيطرة إلى حد ما، و لكن يسود اعتقاد عام أن حضور الأمهات يسبب تشتتاً للأطفال (و الحقيقة أن هذا يقلل من فهم الأمهات لما يدور في الجلسات و تعلمهن كيف يؤدين أدوارهن مع الأطفال في المنزل)، تتم كتابة ملاحظات مسؤولة التأهيل عن الجلسة و أداء الطفل في كراسة الطفل و شرح ذلك للأم بعد الجلسة بشكل جيد و منتظم، كان أداء مسؤولات التأهيل بشكل عام جيد و لكنهن لا يربطن بين الأهداف المختلفة داخل نفس المجال و لا بين المجالات الختلفة بالشكل المناسب.

تقييم تقدم الأطفال:

يتم من خلال حساب نسبة تحقيق الأهداف ال (25) الموضوعة في خطة التدخل (كل 4 شهور)، و في حالة الأطفال الذين يتلقون جلسات بورتيدج تتم المتابعة باعادة حساب العمر التطوري و النسبة التطورية (كل 4 شهور).

تقييم الجلسات و أداء مسؤولات التأهيل:

يتم ذلك من خلال: تقييم الإعداد للجلسة، وضع الأهداف و تحقيقها، و وضع الطفل و أداؤه أثناء الجلسة، و أداء مسؤولة التأهيل للأنشطة و قدرتها على الابتكار و التجديد. و يتم كتابة تقرير بالملاحظات و التوصيات و الاحتياجات و طرق تلبيتها.

تم تقييم الجلسات في هذه المراجعة باستخدام استمارة صممت لهذا الغرض و كانت النسبة المئوية المتوسطة هي (77,9%) و هي نسبة جيدة و تشير درجات الأداءات المختلفة على الاستمارة لاحتياج مسؤولات التأهيل و ظروف تنفيذ الجلسات لبعض التطوير.

تسجيل أنشطة الوحدة:

يتم تسجيل ما يخص الوحدة الكترونياً (كان يتم التسجيل ورقياً في السابق) ، كل مستفيد له ملف الكتروني خاص به يشمل استمارة الاحتياجات و الأنشطة المقدمة له، كما يتم تسجيل حالات الاحالة الكترونياً.

الإتاحة الفيزيقية:

الوحدة ككل غير متاحة فيزيقياً؛ فهي في الدور الأول فوق الأرضي، و السلم ضيق و ليس له درابزين، و صعب استخدامه، و من ثم فلا يحتاج الأمر لمزيد من تقييم سبل الاتاحة في الوحدة، و لكن الوحدة تتضمن حجرة في الطابق الأرضي بجوار السلم المؤدي للدور العلوي، و باب البيت و باب الحجرة بعرض مناسب، و لكن الدور الأرضي مرتفع عن مستوى الأرض و لابد من استخدام سلم من عدة درجات للوصول إليها في حين أنه لا يوجد منحدر، و باستخدام الأداة المختصرة لتقييم الإتاحة الفيزيقية حصلت الوحدة على نسبة 50%، و في الأغلب أنه سيكون من الصعب عمل منحدر بالمواصفات الصحيحة بالنظر لموقع الوحدة و عرض الشارع من ناحية و العدد المحتمل من الأشخاص من مستخدمي الكراسي المتحركة الذين سوف يستخدمونه من ناحية أخرى.

إجراءات الأمن و السلامة و الحماية و الشكاوى:

يتم مراعاة أمن و سلامة و حماية الطفل بشكل عام، إذ يوجد ميثاق أخلاقي و وسياسة للحماية يطّلع عليهما العاملون و يوقعون عليهما، و يعملون على تطبيقهما ولو بشكل غير كامل، و لكن لا يوجد صندوق للشكاوى، و يعتمد نظام العمل على أن من لديه شكوى سيتقدم به للجمعية، و لكن اجراءات الأمن و السلامة و الحماية و الشكاوى تحتاج إلى مزيد من الجهد المنظم لتطبيقها.

الزيارات المنزلية \ الأمهات (القائم بالرعاية)

الأمهات من أسيوط - القوصية - فرازة: (5) أمهات و مقدمات رعاية (إيمان، تهاني، صباح، هيام، نادية) ، و هن يقمن برعاية محمد أحمد– 43 سنة (اعاقة سمعية و بصرية و حركية)، تقوى - 5 سنوات (صعوبات في النطق)، محمد – 4 سنوات (تشتت انتباه و فرط حركة)، إسلام – 13 سنة (نوبات صرعية و مشاكل سلوكية) ، و عبدالله – 6 سنوات (اعاقة ذهنية).

الأسئلة	الإجابات
معرفة الأم بالصعوبات التي تؤثر على الطفل	الجميع يعرفن جيداً حالات الأشخاص ذوي الاعاقة و الصعوبات التي تواجههم بشكل جيد.
معرفة الأم بمدة الحصول على الزيارات المنزلية	الجميع يعرفن المدة التي يحصلن خلالها على زيارات منزلية.
سبب الحصول على زيارة منزلية و عدم الذهاب إلى الوحدة	كانت أهم الأسباب هي رفض الأسرة (2)، و صعوبة الوصول بالطفل بسبب الاعاقة الحركية (2) و صعوبة الحالة بسبب نوبات صرعية (1).
عدد مرات الزيارة المنزلية فى الشهر و ثبات مواعيدها و مدتها	تنفذ جميع الزيارات المنزلية مرتين شهرياً في مواعيد ثابتة و لمدة نحو 45 دقيقة.
ما تقوم به المدربة أثناء الزيارة	يتضمن ما تقوم به المدربة تمرينات حركية، تدريب على الرعاية الذاتية، تمارين للفم و تدريبات على النطق، تدريب على أداء الأعمال المنزلية أو المساعدة فيها، تنمية المهارات، تدريب على تمييز مصادر الخطر، تدريبات أكاديمية، تدريب على الخروج من المنزل و التعامل مع البيئة الخارجية.
ما تقوم به الأم أثناء الزيارة	تساعد الأمهات المدربات أثناء الجلسة و يلاحظن ما تقوم به المدربات ليتعلمن منهن.
ما تقوم به الأم في الأيام التي لا تحدث بها الزيارة	يتعاملن مع الأشخاص ذوي الاعاقة بأساليب مناسبة، و ينفذن التمرينات و التدريبات المختلفة.
استفادة الطفل\الشخص من الزيارات المنزلية	تحسن الحالة النفسية ، و تحسن بعض السلوكيات و المهارات و الأداءات (النطق و الفهم و الكلام و الرعاية الذاتية و الاعتماد على النفس و الاستجابة و التعامل مع الأخرين ..)
استفادة الأم من الزيارة المنزلية	تحسن طريقة تعاملهن مع الأشخاص ذوي الاعاقة و رعايتهم، و تحسن فهمهن و تقبلهن للحالة و الاحساس بالأمل و التفاؤل و الدعم.
ما يضايق الأم في الزيارة المنزلية؟	لم تشر أي من الأمهات إلى أي شيء يضايقهن أثناء الزيارات على الاطلاق.

الدمج و الأنشطة الدامجة \ الأمهات (القائم بالرعاية)

الأمهات من أسيوط - القوصية - فرازة: (5) أمهات (صفاء و هناء و وردة و هبة و عائشة)، و هن يقمن برعاية آية – 10 سنوات (مشاكل سلوكية)، محمد و خالد – 9 و 10 سنوات (صعوبات تعلم)، خالد – 3 سنوات (تأخر في الكلام) ، و عبد الله – 6 سنوات (فرط حركة و تشتت انتباه) و فوزي و محمد 6 و 8 سنوات (صعوبات تعلم و فرط حركة)

الأسئلة	الإجابات
معرفة الأم بالصعوبات التي تؤثر على الطفل	الجميع يعرفن جيداً حالات الأشخاص ذوي الاعاقة و الصعوبات التي تواجههم بشكل جيد.
مكان دمج الطفل و السنة الدراسية إن أمكن	الأطفال في سن المدرسة مندمجين في مدارس ابتدائية (آية و محمد و خالد و عبدالله و فوزي) و الأصغر مندمجين في حضانات (خالد و محمد)
كيف تمكنت الأسرة من دمج الطفل	جميع الأطفال تم دمجهم في المدارس و الحضانات بالاجراءات المتبعة و بدون صعوبات
الصعوبات التي واجهت دمج الطفل	الأطفال مندمجين في الدراسة و لكن مستوى التعليم بشكل عام ضعيف.
كيف ساعدت وحدة التأهيل المرتكز على المجتمع في عملية دمج الطفل	لم تساعد الوحدة في اجراءات الدمج في المدارس، سوى حالة واحدة تم دمجه في الحضانة التي تديرها الجمعية.
الأنشطة اللي قامت بها الوحدة لمساعدة ادماج الطفل (أنشطة دامجة .. جلسات تنمية مهارات و قبل أكاديمي .. رحلات .. فعاليات في المجتمع ..) حالة الطفل في مكان الدمج في الوقت الحالي	الأطفال المندمجين منتظمون في جلسات (تعديل سلوك و تنمية مهارات و تنمية لغة و أكاديمي) و يشاركون في الأنشطة الدامجة. و حالتهم في المدارس و الحضانات تحسنت كثيراً
الصعوبات التي تواجه الطفل في مكان الدمج في الوقت الحالي	لم تشكو الأمهات من أي مشكلة حالياً و أفدن أن مشاكل الدمج ربما كانت موجودة في البداية و قلت كثيراً مع الوقت.
مساعدة وحدة التأهيل المرتكز على المجتمع في نجاح الطفل في مكان الدمج في الوقت الحالي	الوحدة تساعد من خلال الجلسات و الأنشطة الدامجة و ليس من خلال أنشطة في المدارس.
المشاركة في (أنشطة دامجة .. جلسات تنمية مهارات و قبل أكاديمي .. رحلات .. فعاليات في المجتمع .. فعاليات في المدارس و الحضانات .. ..)	شاركت الأمهات و الأطفال في جولات حرة و حفلات و رحلات دامجة.

(ج) وحدة كوم المنصورة في أسيوط

سير العمل و فرق العمل

فرق العمل:

تكوين الفريق:

يتكون فريق العمل من: مدير مكتب أسيوط "مروة يوسف"، و مدير فني المكتب "صفية عبد المنعم" (تشرف على 6 وحدات في المحافظة)، و "سناء خليفة" منسق المشروع (تشرف على 15 وحدة في أسيوط)، و "آيات علي" منسق التأهيل في المكتب (لعدد من الوحدات)، و "هدير أحمد" مشرف فني للوحدات (لعدد من الوحدات)، و (3) مسؤولات تأهيل "أميمة ، مروة ، فاطمة" (في وحدة كوم المنصورة)

وظائف الفريق: (مرفق التوصيف الوظيفي للفرق الفنية)

المستوى الفني للفريق:

المستوى الفني **للمدير الفني للمكتب** "صفية عبد المنعم" عالي جداً ، من خلال الحصول على الكثير من التدريب و تكوين خبرات قوية من خلال العمل في كيان و خارجها و اتقان أحد التخصصات المهمة في مجال التأهيل (مونتسوري)، و المستوى يناسب طبيعة المهام الوظيفية.

المستوى الفني **للمشرف الفني للوحدات** "هدير أحمد" جيد جداً، من خلال مؤهل مناسب ، و الحصول على الكثير من التدريب (بورتيدج، تعديل سلوك، اختبار فاينلاند، اختبار الذكاء، التكامل الحسي و تكوين خبرات قوية من خلال العمل في كيان و خارجها، و هو يناسب طبيعة المهام الوظيفية.

المستوى الفني **لمنسق التأهيل بالمكتب** "آيات علي" جيد، و حصلت على بعض التدريبات و إن كانت خبرتها قصيرة داخل و خارج كيان، و المستوى واعد و لكنه لا يزال يحتاج للتطوير كي يناسب طبيعة المهام الوظيفية.

المستوى الفني **لمسؤولات التأهيل** مقبول، و قد حصلن على عدد من أيام التدريب المبدئي نظراً لالتحاقهم بالعمل من شهور قليلة، كما يحصلن على تدريبات على رأس العمل، و المستوى يحتاج للمزيد من التطوير من خلال استكمال برامجهم التدريبية و توفير المزيد من المتابعة و الإشراف و التدريب على رأس العمل خلال الفترة القادمة لرفع المستوى الفني ليناسب طبيعة المهام الوظيفية.

أسلوب و سير العمل:

كفاءة العمل الفني:

العمل مع الفئات العمرية المختلفة من الجنسين:

تخدم وحدة كوم المنصورة 61 (42%) من الذكور و 85 (58%) من الإناث، و 75 (51%) من الأطفال و 71 (49%) من البالغين.

(بناءً على قاعدة بيانات المشروع)

أنواع الإعاقات:

تتضمن أنواع الإعاقات: تأخر ذهني، تأخر لغوي، صعوبات تعلم (قد تكون هناك صعوبات في التشخيص المعطى لبعض الحالات)، توحد (قد تكون هناك صعوبات في التشخيص المعطى لبعض الحالات)، تشتت انتباه و فرط حركة، اعاقات سمعية، اعاقات حركية، ..

أنواع الجلسات المقدمة و نوعية حالات المستفيدين:

تقدم الوحدة أنواعاً مختلفة من الجلسات و الخدمات، و قد قدمت بالفعل (615) جلسة، في الوحدة و (720) زيارة منزلية، تقدم الوحدة جلسات التدخل ل (119) من الأشخاص ذوي الإعاقة (حالات منتظمة شهرياً)، كما قدمت جولات حرة و ندوات للتوعية و أيام ترفيهية.

نوع الإعاقة	عدد المستفيدين	أنواع الجلسات المقدمة
تأخر ذهني	65	جلسات تنمية القدرات جلسات تنمية مهارات لغوية تنمية المهارات الحسية إدارة المشكلات السلوكية إرشاد للأسر زيارات منزلية
متلازمة داون	1	
اضطراب التوحد	1	
اضطراب فرط الحركة ونقص الإنتباه	6	
شلل دماغي	15	جلسات تأهيل حركي جلسات تنمية المهارات اللغوية جلسات تنمية المهارات الحسية اللغوية جلسات تنمية المهارات الحسية إرشاد أسري
ضمور في العضلات	1	
اضطراب التعلم المحدد	1	جلسات تأهيل أكاديمي جلسات تنمية مهارات لغوية إدارة المشكلات السلوكية إرشاد للأسر
اضطرابات النطق والكلام	0	جلسات تصحيح اللدغات إدارة المشكلات السلوكية إرشاد للأسر الإحالة للمراكز المتخصصة
اعاقة سمعية	7	جلسات تأهيل سمعي إدارة المشكلات السلوكية إرشاد للأسر الإحالة للمراكز المتخصصة

إعاقة بصرية	18	الإحالة للمراكز المتخصصة (كيان) إرشاد أسري إرشاد للشخص نفسه
إعاقات متعددة	17	جلسات تنمية القدرات جلسات تنمية مهارات لغوية إدارة المشكلات السلوكية إرشاد للأسر زيارات منزلية
عيوب التمثيل الغذائي	2	زيارات منزلية
أخري	52	جلسات تنمية القدرات جلسات تنمية مهارات لغوية إدارة المشكلات السلوكية إرشاد للأسر زيارات منزلية

نوع الجلسة (بصرف النظر عن نوع الإعاقة)	عدد الجلسات
لا يوجد تقسيم متبع بالوحدة خاص بتفصيل الجلسات جاري تحسين الوضع	عدد (615) جلسة حتى شهر سبتمبر

نوع الخدمة\النشاط	عدد الجلسات
جولات حرة	عدد (5) جولات **14)** مستفيد)
ندوات توعية	عدد (3) ندوات **)** 37 مستفيد **(**
(الزيارات المنزلية)	**720**
المساعدات الإجتماعية	
توزيع ملابس	**103**
توزيع بطاطين	**103**
توفير علاج دوائي	**1**
كارت الخدمات	**1**
توزيع مواد غذائية	**13**
توزيع لحوم أضاحي	**44**
الاحالات	**11**

تقييم الأطفال و حالات الزيارات المنزلية:

يتم تقييم الأطفال باستخدام مجموعة من الأدوات منها: قائمة بورتيدج، استمارات و أدوات تقييم سمعي، حسي (بصري و سمعي)، أكاديمي، مجموعات ضمنية، تقييم الأصوات، مشكلات سلوكية، صعوبات تعلم، .. يتم تحديد العمر التطوري و النسبة التطورية للأطفال تحت سن (6) سنوات، أما الأطفال فوق هذا السن فلا تحدد لهم نسبة تطورية و لكن يتم تحديد ما يستطيعون القيام به، أما حالات الزيارة المنزلية فيتم معها استخدام قائمة الاحتياجات المرفقة بكتيبات منظمة الصحة العالمية عن التأهيل المرتكز على المجتمع.

وضع خطط التدخل:

يتم وضع خطط التدخل للأطفال الذين سيحصلون على جلسات بالوحدة (سواء ماقبل أو ما بعد (6) سنوات) بناء على نتائج التقييم، فيتم وضع (25) هدف، بواقع (5) أهداف في كل من المجالات الخمسة لتطور الطفل (الحركي، المعرفي، الاجتماعي، اللغوي، و رعاية الذات)، و في حالة الزيارات المنزلية يتم اختيار الأهداف بناء على التقييم الذي تم بواسطة قائمة الاحتياجات المرفقة بكتيبات منظمة الصحة العالمية عن التأهيل المرتكز على المجتمع، و تغطي الخطة (4) أشهر.

وضع أهداف الجلسات و تنفيذها:

يتم اختيار أهداف كل جلسة من أهداف خطة التدخل التي تم وضعها مسبقاً، و يتم تنفيذ الجلسات في حجرة واسعة و مضاءة جيداُ و ذات تهوية جيدة و تسمح بحركة الطفل و مسؤولة التأهيل بشكل مناسب، الأدوات المطلوبة لأداء الجلسات متوفرة بشكل مناسب، الجلسات الت تمت ملاحظتها كان الأطفال يجلسون على الكرسي و أمامهما المنضدة بعض الوقت و يتحركون بعض الوقت، حضرت إحدى الأمهات في الجلسة حيث كانت الطفلة صغيرة و تحتاج لوجود الأم، و حضرت أم أخرى جزء من الجلسة للمساعدة في التحكم في الطفل و حركته بعدما خرج عن السيطرة إلى حد ما، و لكن يسود اعتقاد عام أن حضور الأمهات يسبب تشتتاً للأطفال (و الحقيقة أن هذا يقلل من فهم الأمهات لما يدور في الجلسات و تعلمهن كيف يؤدين أدوارهن مع الأطفال في المنزل)، تتم كتابة ملاحظات مسؤولة التأهيل عن الجلسة و أداء الطفل في كراسة الطفل و شرح ذلك للأم بعد الجلسة بشكل جيد و منتظم، كان أداء مسؤولات التأهيل بشكل عام جيد و لكنهن لا يربطن بين الأهداف المختلفة داخل نفس المجال و لا بين المجالات الختلفة بالشكل المناسب.

تقييم تقدم الأطفال:

يتم من خلال حساب نسبة تحقيق الأهداف ال (25) الموضوعة في خطة التدخل (كل 4 شهور)، و في حالة الأطفال الذين يتلقون جلسات بورتيدج تتم المتابعة باعادة حساب العمر التطوري و النسبة التطورية (كل 4 شهور).

تقييم الجلسات و أداء مسؤولات التأهيل:

يتم ذلك من خلال: تقييم الإعداد للجلسة، وضع الأهداف و تحقيقها، و وضع الطفل و أداؤه أثناء الجلسة، و أداء مسؤولة التأهيل للأنشطة و قدرتها على الابتكار و التجديد. و يتم كتابة تقرير بالملاحظات و التوصيات و الاحتياجات و طرق تلبيتها.

تم تقييم الجلسات في هذه المراجعة باستخدام استمارة صممت لهذا الغرض و كانت النسبة المئوية المتوسطة هي (61.7%) و هي نسبة ضعيفة، و تشير درجات الأداءات المختلفة على الاستمارة لاحتياج مسؤولات التأهيل و ظروف تنفيذ الجلسات لبعض التطوير.

تسجيل أنشطة الوحدة:

يتم تسجيل ما يخص الوحدة الكترونياً (كان يتم التسجيل ورقياً في السابق) ، كل مستفيد له ملف الكتروني خاص به يشمل استمارة الاحتياجات و الأنشطة المقدمة له، كما يتم تسجيل حالات الاحالة الكترونياً.

الإتاحة الفيزيقية:

الوحدة متاحة فيزيقياً بدرجة مناسبة؛ فهي في الدور الأرضي، ، و باب الوحدة و باب الحجرة التي تتم فيها الجلسات بعرض مناسب، و لكن الدور الأرضي نفسه مرتفع عن مستوى الأرض و لابد من استخدام سلم من عدة درجات للوصول إليها في حين أن المكان يسمح بعمل منحدر و بسطة أمام المدخل، و باستخدام الأداة المختصرة لتقييم الإتاحة الفيزيقية حصلت الوحدة على نسبة 50%، و في الأغلب أنه يمكن عمل منحدر بالمواصفات الصحيحة، و عمل اتاحة لدورة مياه واحدة، و تزويد الوحدة بكرسي متحرك، و تنظيم كيفية الوصول إلى مترجم لغة لإشارة إذا لزم الأمر ؛ فتتحسن بذلك درجة اتاحة الوحدة.

إجراءات الأمن و السلامة و الحماية و الشكاوى:

يتم مراعاة أمن و سلامة و حماية الطفل بشكل عام، إذ يوجد ميثاق أخلاقي و وسياسة للحماية يطّلع عليهما العاملون و يوقعون عليهما، و يعملون على تطبيقهما ولو بشكل غير كامل، و لكن لا يوجد صندوق للشكاوى، و يعتمد نظام العمل على أن من لديه شكوى سيتقدم به للجمعية، و لكن اجراءات الأمن و السلامة و الحماية و الشكاوى تحتاج إلى مزيد من الجهد المنظم لتطبيقها.

الزيارات المنزلية \ الأمهات (القائم بالرعاية)

الأمهات من أسيوط – أبنوب – كوم المنصورة: (5) أمهات (حميدة، يسرية، نفيسة، آية، و منى) ، و هن يقمن برعاية محمد سيد – 12 سنة (اعاقة سمعية و بصرية و فرط حركة)، سلمى -12 سنة (مشكلة في إحدى العينين)، نورا 16 سنة (مرض البول السكري الخلقي)، آية – 8 سنوات (اعاقة حركية) ، و جيهان 19 سنة (اعاقة ذهنية).

الأسئلة	الإجابات
معرفة الأم بالصعوبات التي تؤثر على الطفل	الجميع يعرفن جيداً حالات الأشخاص ذوي الاعاقة و الصعوبات التي تواجههم بشكل جيد.
معرفة الأم بمدة الحصول على الزيارات المنزلية	الجميع يعرفن المدة التي يحصلن خلالها على زيارات منزلية.
سبب الحصول على زيارة منزلية و عدم الذهاب إلى الوحدة	كان أهم الأسباب هو عدم الاحتياج لأخذ جلسات في الوحدة و أن الزيارة
عدد مرات الزيارة المنزلية فى الشهر و ثبات مواعيدها و مدتها	تنفذ جميع الزيارات المنزلية مرتين شهرياً في مواعيد ثابتة و لمدة نحو 45 دقيقة.

ما تقوم به المدربة أثناء الزيارة	يتضمن ما تقوم به المدربة توعية و توجيه و ارشاد و دعم بخصوص رفع المعنويات، و النظافة الشخصية، و الترتيب، و الاعتماد على النفس في الأكل و الشرب و الحمام، و التعاون في المنزل، و السلوكيات، و ممارسة أوجه الحياة المختلفة،
ما تقوم به الأم أثناء الزيارة	تساعد الأمهات المدربات أثناء الجلسة و يلاحظن ما تقوم به المدربات ليتعلمن منهن.
ما تقوم به الأم في الأيام التي لا تحدث بها الزيارة	يتعاملن مع الأشخاص ذوي الاعاقة بأساليب مناسبة، و ينفذن التمرينات و التدريبات المختلفة.
استفادة الطفل\الشخص من الزيارات المنزلية	تحسن الحالة النفسية و المعنوية ، و تحسن بعض السلوكيات و المهارات و الأداءات (التركيز و الأداء المدرسي و الرعاية الذاتية و الاعتماد على النفس و المشاركة و الاستجابة و التعامل مع الأخرين و الخروج خارج المنزل ..)
استفادة الأم من الزيارة المنزلية	تحسن طريقة تعاملهن مع الأشخاص ذوي الاعاقة و رعايتهم، و تحسن فهمهن و تقبلهن للحالة و الاحساس بالأمل و التفاؤل و الدعم.
ما يضايق الأم في الزيارة المنزلية؟	لم تشر أي من الأمهات إلى أي شيء يضايقهن أثناء الزيارات على الاطلاق.

الدمج و الأنشطة الدامجة \ الأمهات (القائم بالرعاية)

الأمهات من أسيوط – أبنوب – كوم المنصورة: (4) أمهات (نجوى، سهرة، نسمة، نادية)، و هن يقمن برعاية أدم – 6 سنوات (صعوبات في الكلام)، إسلام - 6 سنوات (صعوبات تعلم)، زياد – 5 سنوات (فرط حركة صعوبات تعلم) ، و ملك – 8 سنوات (فرط حركة و تشتت انتباه)

الأسئلة	الإجابات
معرفة الأم بالصعوبات التي تؤثر على الطفل	الجميع يعرفن جيداً حالات الأشخاص ذوي الاعاقة و الصعوبات التي تواجههم بشكل جيد.
مكان دمج الطفل و السنة الدراسية إن أمكن	الأطفال في سن المدرسة مندمجين في مدارس ابتدائية (آية و محمد و خالد و عبدالله و فوزي) و الأصغر مندمجين في حضانات (خالد و محمد)
كيف تمكنت الأسرة من دمج الطفل	جميع الأطفال تم دمجهم في المدارس و الحضانات بالاجراءات المتبعة و بدون صعوبات
الصعوبات التي واجهت دمج الطفل	الأطفال مندمجين في الدراسة و لكن مستوى التعليم بشكل عام ضعيف.
كيف ساعدت وحدة التأهيل المرتكز على المجتمع في عملية دمج الطفل	لم تساعد الوحدة في اجراءات الدمج في المدارس، سوى حالة واحدة تم دمجه في الحضانة التي تديرها الجمعية.
الأنشطة اللي قامت بها الوحدة لمساعدة ادماج الطفل (أنشطة دامجة .. جلسات تنمية مهارات و قبل أكاديمي .. رحلات .. فعاليات في المجتمع ..) حالة الطفل في مكان الدمج في الوقت الحالي	الأطفال المندمجين منتظمون في جلسات (تعديل سلوك و تنمية مهارات و تنمية لغة و أكاديمي) و يشاركون في الآنشطة الدامجة. و حالتهم في المدارس و الحضانات تحسنت كثيراً
الصعوبات التي تواجه الطفل في مكان الدمج في الوقت الحالي	لم تشكو الأمهات من أي مشكلة حالياً و أفدن أن مشاكل الدمج ربما كانت موجودة في البداية و قلت كثيراً مع الوقت.

مساعدة وحدة التأهيل المرتكز على المجتمع في نجاح الطفل في مكان الدمج في الوقت الحالي	الوحدة تساعد من خلال الجلسات و الأنشطة الدامجة و ليس من خلال أنشطة في المدارس.
المشاركة في (أنشطة دامجة .. جلسات تنمية مهارات و قبل أكاديمي .. رحلات .. فعاليات في المجتمع .. فعاليات في المدارس و الحضانات .. ..)	شاركت الأمهات و الأطفال في جولات حرة و حفلات و رحلات دامجة.

3. أهم الخلاصات و التوصيات

3.1. أهم الخلاصات

1- يعمل المشروع بدرجة جيدة جداً من الكفاءة الفنية ، و ذلك من خلال نظام كفء للإدارة الفنية و لتقديم الخدمات، و قدرات فنية عالية لفريق العمل على المستويات المختلفة (خاصة على المستويات الأعلى).

2- تحتاج بعض عناصر الفريق الفني لرفع كفاءتها في جوانب قدراتها الفنية و طريقة تشغيلها؛ و من ذلك:

a. بعض أعضاء فريق الإدارة الفنية في المستوى المتوسط يحتاجون للمزيد من بناء القدرات و الكفاءات ليتمكنوا من دعم مسؤولات التأهيل في وحدات التأهيل، في جوانب فنية متعلقة بالجلسات مثل تحديد الأهداف بما يناسب كل حالة و وضع سيناريو للجلسات و تنفيذ أنشطة تخدم أهدافاً و مجالات متعددة، و في جوانب تتصل بمجالات أخرى من مصفوفة التأهيل المرتكز على المجتمع.

b. بالرغم من أن المستوى الفني لغالبية مسؤولات التأهيل جيد إلى جيد جداً من الكفاءة في تقديم الجلسات (كان متوسط درجة الجودة باستخدام أداة التقييم المستخدمة في هذه المراجعة هي (78,1 %) لمسؤولات وحدة "المنشأة بسوهاج"، (77,9%) لمسؤولات وحدة "فرازة بأسيوط")، إلا أن البعض منهن كان مستواهن متوسط (كان متوسط درجة الجودة في وحدة "كوم المنصورة بأسيوط" (61.7%) فقط)؛ حيث أن المسؤولات هناك بدأن العمل من شهور قليلة و لم يكملن بعد تدريبهن الأساسي.

c. تفتقد معظم مسؤولات التأهيل لبعض المهارات مثل تحديد الأهداف بما يناسب كل حالة و وضع سيناريو للجلسات و تنفيذ أنشطة تخدم أهدافاً و مجالات متعددة، التعامل مع الحالات الأصعب و مع الأوقات و المواقف الصعبة أثناء الجلسات، تنفيذ الجلسات في وجود الأمهات.

3- ظروف العمل قد تكون غير مواتية تماماً في بعض الأحيان، و من ذلك:

a. يبدو أن عبء العمل شديد على بعض القيادات الفنية؛ مثل القيام بمهام المدير الفني بجانب مهام المسؤولية الفنية عن خدمة متخصصة (مثل مونتسوري أو التكامل الحسي)، أو الإشراف الفني على عدد كبير من الوحدات .. مما يصعب أداء المسؤوليات المختلفة بالكفاءة المطلوبة.

b. يشكّل ترك بعض مسؤولات التأهيل العمل في المشروع مشكلة؛ خاصة إذا حدث ذلك بشكل مفاجيء (ربما هذا ما حدث في كوم المنصورة و وحدات أحرى)، خاصة في عدم وجود متطوعات مدربات يساعدن مسؤولات التأهيل بالشكل المناسب.

c. بعد بعض الوحدات جغرافياً عن مكان وجود الدعم الفني، مما يجعل الفريق الفني يخسر ساعات طويلة في الانتقالات (كوم المنصور مثلاً .. و هناك ما هو أبعد فيما أظن).
d. بعض أماكن تنفيذ الجلسات غير مناسبة من حيث المساحة و تلاصق الحجرات (المنشأة مثلاً)

4- تنفذ مسؤولات التأهيل الجلسات بشكل جيد بشكل عام، و لكن لا تحضر الأمهات في أغلب الجلسات، و ربما يسود اعتقاد عام بأن حضور الأمهات يسبب تشتتاً للأطفال (صحيح أن مساحة الغرف ربما لا تسمح أحياناً بتواجد الأمهات بشكل مناسب، و لكن عدم حضورهن يقلل من فهمهن لما يدور في الجلسات و تعلمهن كيف يؤدين أدوارهن مع الأطفال في المنزل).
5- يعمل المشروع مع الأشخاص ذوي الإعاقة من الجنسين في فئتي الأطفال و البالغين بشكل متوازن جداً، إذ تبلغ نسبة المستفيدين من الذكور (49,5%) و من الإناث (51,5%)، و من الأطفال (43,5%) و من البالغين (56,5%).
6- . يعمل المشروع مع أنواع مختلفة من الإعاقات منها الذهنية و البصرية و السمعية و الحركية و طيف التوحد، و هذا أمر جيد، و لكن أعداد و نسب أنواع الإعاقة متباينة؛ فمن العددالكلي للأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من الخدمات في الوحدات الثلاثة و الذي يبلغ (451)، تمثل الإعاقة الذهنية و ما يرتبط بها من حالات نسبة (35%)، و تمثل الإعاقة البصرية (10%)، و تمثل الإعاقة السمعية و ما يرتبط بها من حالات (10%) و تمثل الإعاقة الحركية و ما يرتبط بها من حالات (10%) و تمثل إعاقة طيف التوحد (1%) و الإعاقات المتعددة (10%) و الحالات الغير محددة (23%).
7- هناك بعض مسميات الإعاقات تحتاج للمراجعة (مثل الإصابات الدماغية) و بعض الأنواع تحتاج لمراجعة المواصفات التي تصنفها تحت مسمى تشخيصي معين (مثل صعوبات التعلم و ربما ضمور العضلات)، و بعض مسميات الاعاقات المستخدمة تحتاج إلي ضمها معاً تحت مسمى واحد (مثل الإعاقة الحركية .. لتسمح بوضع تشخيصات أخرى لم يستخدمها المشروع مثل روماتيزم المفاصل أو التهاب الأعصاب الطرفية أو الشلل النصفي السفلي أو الطولي ....).
8- هناك العديد من الحالات (23%) غير محددة تحت أي مسمى، و هذه نسبة كبيرة نسبياً، و تحتاج للمراجعة.
9- يقدم المشروع أنواع مختلفة من الخدمات و الجلسات، و هذا شيء جيد، إلا أن نسبة الخدمات الجماعية المقدمة للأسر أو للأطفال قليلة جداً مقارنة بالجلسات الفردية و الزيارات المنزلية، و هناك احتياج لزيادة الاهتمام بهذه الخدمات مثل أنشطة الأيام الترفيهية و الجولات الحرة و ندوات و ورش عمل الأمهات، لتأثيرها الكبير و الواسع على المستفيدين و المجتمع.
10- هناك احتياج لتحديد و توحيد المسميات المستخدمة لأنواع الجلسات و الخدمات (مثلاً تذكر جلسات التأهيل الحركي و تنمية المهارات الحسية في بعض الوحدات و لا تذكر كنوع محدد من الجلسات في وحدات أخرى مثل "المنشأة").
11- أعداد الأنواع المختلفة من الجلسات التي تقدم في الوحدة غير محددة في بعض الوحدات مثل "فرازة " و "كوم المنصورة".
12- يستخدم المشروع طريقة موحدة و بنفس الطريقة دائماً في وضع الأهداف المخطط تحقيقها في خطط التدخل (25 هدف في 5 مجالات، بناءً على نتائج التقييم بالقوائم الارتقائية أو استمارة تحديد الاحتياجات) يتم العمل عليها لمدة (4) شهور، و أحياناً يتم الإضافة إليها إذا احتاج الأمر، و هذه طريقة جيدة. إذ أنها تساعد على توحيد طريقة العمل بين الوحدات و تسهيل متابعة تطور الطفل و أداء مسؤولات التأهيل.

13- إلا أن وضع نفس عدد الأهداف دائماً للأطفال مهما اختلفت قدراتهم و مستوى تطورهم يؤدي أحياناً إلي أخذ انطباعاً خاطئاً عن تطور الطفل و أداء مسؤولة التدريب ؛ بالزيادة في الحالات البسيطة الإعاقة و بالنقص في الحالات الشديدة الإعاقة.
14- يظهر الأطفال الذين يتلقون جلسات في الوحدات تحسناً ملموساً كمياً و كيفياً، إذ تراوحت نسبة تحقيق الأهداف بين 50% و 82% بمتوسط 71%، و هذه نسبة جيدة، كما يظهر الأشخاص الذين يتلقون زيارات منزلية تحسناً ملموساً كيفياً.
15- لا يوجد رصد لتقدم الأطفال خاصة أثناء فترة تنفيذ الخطة (4 شهور) في الملف على شكل تقرير مختصر عن تقدم الحالة بصفة شهرية (مثلاً) يوضح مدى تقدم الحالة بشكل واضح و يكون مكوناً أساسياً في ملف كل طفل.
16- استفادت جميع الأمهات اللاتي تمت مقابلتهن (36) من الخدمات المقدمة، و ذلك في جوانب؛ الاحساس بتقدم الأطفال و بالتفاؤل و بالثقة في النفس و بأن هناك من يدعمهن و يهتم بهن و بأطفالهن، و اكتساب مهارات التعامل مع الأطفال بشكل أفضل و مساعدتهم في أداء الواجبات المنزلية و تدريبهم على الأداءات و السلوكيات المطلوبة.
17- قواعد البيانات للوحدات ممتازة و شاملة و مستخدمة.
18- ينقص القواعد بعض النقاط لتحسين كفاءتها في الجوانب الفنية و أهمها: إضافة نوع الجلسات الفنية بقدر أكبر من التفصيل (مثل ما هو مكتوب بالفعل عن الخدمات الاجتماعية مثلاً)، مراجعة أنواع الإعاقة المستخدمة (و التي تحتاج للتعديل و الإضافة و الحذف) و إضافة وصف أو تحديد للتقدم الذي يحرزه الشخص ذو الإعاقة.
19- بعض الوحدات غير متاحة فيزيقياً على الإطلاق؛ فهي في الدور الأول فوق الأرضي، و السلالم ضيقة و ليس لها درابزين، و صعب استخدامها حتى للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية الذين يستطيعون الوقوف و المشي (المنشأة)، و الوحدات التي في الدور الأرضي (كوم المنصورة)، أو التي لديها جزء في دور أرضي (فرازة) تكون أحياناً مرتفعة عن سطح الأرض و بها سلم أيضاً بارتفاع بعض الدرجات، و ليس بها منحدر،كما أن دورات المياه في الأغلب ليست متاحة.
20- تتم مراعاة أمن و سلامة و حماية الطفل بشكل عام، إذ يوجد ميثاق أخلاقي و وسياسة للحماية يطّلع عليهما العاملون و يوقعون عليهما، و يعملون على تطبيقهما (و هذا شيء جيد)، و لكنه يتم بشكل غير كامل و غير محكم، كما لا يوجد صندوق للشكاوى، و يعتمد نظام العمل على أن من لديه شكوى سيتقدم به للجمعية المحلية المنفذة، و هذا لا يوفر الدرجة المطلوبة من الحماية.

3.2. أهم التوصيات

1. استكمال تدريب أعضاء فريق الإدارة الفنية في المستوى المتوسط من خلال بعض التدريبات المتخصصة و تبادل الخبرات و اكتساب المزيد من المهارات على رأس العمل، ليتمكنوا من دعم مسؤولات التأهيل في الوحدات بالتدريب و الإشراف اللازمين.
2. استكمال تدريب مسؤولات التأهيل ممن لم يكملن تدريبهن الأساسي في "كوم المنصورة" و في أي وحدات أخرى في وضع مشابه.
3. استكمال تدريب مسؤولات التأهيل في المشروع ككل خاصة فيما يتعلق بنقاط الضعف التي تمت الاشارة إليها سلفاً، و منها تحديد الأهداف بما يناسب كل حالة و وضع سيناريو للجلسات و تنفيذ أنشطة تخدم أهدافاً و مجالات متعددة، التعامل مع الحالات الأصعب و مع الأوقات و المواقف الصعبة أثناء الجلسات، تنفيذ الجلسات في وجود الأمهات.

4. تقييم و متابعة أداء مسؤولات التأهيل باستخدام استمارة بسيطة و محددة و موحدة للتقييم ، يتم تطبيقها ربع سنوياً خاصة لتقييم للمسؤولات الجدد، و يمكن أن يصبح التطبيق نصف سنوياً بعد ذلك.
5. استخدام تقنيات متطورة أونلاين للتواصل مع فرق وحدات التأهيل، لكسب مزيد من الوقت و تكثيف الاستفادة من قدرات فريق الاشراف الفني.
6. العمل على حل إزدواجية المسؤوليات الفنية ما أمكن خاصة فيما يخص القيادات الفنية الأعلى مستوى.
7. العمل على حل عدم مناسبة بعض أماكن تقديم الجلسات ما أمكن.
8. يفضل حضور الأمهات و مشاركتهن في الجلسات كلما أمكن ذلك، لما في ذلك من فوائد للأم و الطفل، و خاصة فيما يرتبط بأداء الأمهات مع الأطفال في المنزل.
9. العمل على ابقاء عدد مناسب من المتطوعات مدربات بشكل جيد، يساعدن مسؤولات التأهيل و على استعداد ليحللن محلهن إذا ما تركت مسؤولة تأهيل أو أكثر العمل لأي سبب.
10. العمل على مراجعة عملية تحديد أنواع الحالات و تحديد أسس سليمة و متفق عليها و موحدة، و ذلك بواسطة المدير الفني لكيان مع المدراء الفنيين للمحافظات و المشرفين الفنيين.
11. العمل على الوصول بشكل أكبر للإعاقات التي تتلقى الخدمات بشكل أقل في المشروع، مثل طيف التوحد و الإعاقات البصرية (خاصة الشديدة) و السمعية (خاصة الشديدة) و الحركية.
12. العمل على محاولة تحديد أنواع الإعاقات غير المحددة حيث تمثل عدداً كبيراً نسبياً (105 حالة في المشروع- 23%)
13. العمل على زيادة الاهتمام بتقديم الخدمات الجماعية مثل أنشطة الأيام الترفيهية و الجولات الحرة و الندوات المجتمعية و ورش عمل الأمهات، لتأثيرها الكبير و الواسع على المستفيدين و المجتمع.
14. العمل على تكوين و دعم مجموعات الدعم الأسري بشكل أقوى.
15. هناك احتياج لتحديد و توحيد المسميات المستخدمة لأنواع الجلسات (مثل التأهيل الحركي و تنمية المهارات الحسية) و الخدمات.
16. هناك احتياج لتجميع أعداد الأنواع المختلفة من الجلسات التي تقدم في الوحدة بكل من "فرازة" و "كوم المنصورة"، و باقي وحدات المشروع التي لا تقوم بذلك.
17. يفضل أن يتم تدريب مسؤولات التدريب على وضع أهداف تتناسب مع مستوى و سرعة تطور الطفل مع الاحتفاظ بكون عدد الأهداف ثابت (5 في كل مجال)، و ذلك عن طريق تقسيم الأهداف لأهداف جزئية في الحالات الصعبة و ربما جمع عدة أهداف في هدف واحد في الحالات البسيطة.
18. العمل على تنفيذ آلية لرصد تطور الحالات أطفالاً أو بالغين ممن يتلقون جلسات بالوحدة أو زيارات منزلية، مثلاً كتابة تقرير مختصر عن تقدم الحالة بصفة شهرية يوضح مدى تقدم الحالة بشكل واضح و يكون مكوناً أساسياً في ملف كل طفل.
19. العمل على متابعة التسجيل و حسن استخدام قواعد بيانات الوحدات، و كذا تحسين كفاءتها في بعض الجوانب الفنية و أهمها: إضافة نوع الجلسات الفنية بقدر أكبر من التفصيل (مثل الخدمات الاجتماعية مثلاً)، مراجعة أنواع الإعاقة المستخدمة (و التي تحتاج للتعديل و الإضافة و الحذف) و إضافة وصف أو تحديد للتقدم الذي يحرزه الشخص ذو الإعاقة.
20. العمل على مراجعة الاتاحة الفيزيقية لكافة الوحدات، و دراسة حالة كل وحدة على حدة لتقدير حجم مشكلة الاتاحة و التحديات الناتجة عنها و امكانيات التصدي لها بحلول ذكية.
21. العمل على اتخاذ خطوات مدروسة جيداً للأمام في اتجاه تطبيق أفضل لسياسة الحماية و تفعيل أقوى لنظام الشكاوى و مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة و أسرهم في الإدارة المحلية لوحدات المشروع.

4. ملاحق

4.1. أدوات جمع البيانات

4.1.1. استبيان وحدات التأهيل.

استمارة مسؤول وحدة التأهيل

(ترسل و تملأ مسبقاً .. على الكومبيوتر إن أمكن)

اسم الوحدة:

اسم المسؤول:

تاريخ المقابلة:

- إيه عدد المدربات اللي بيشتغلوا في الوحدة؟
- نظام الدوام عندكم ايه؟
- إيه عدد الحالات اللي تم التدخل معاها في الوحدة في الفترة السابقة؟
- ايه متوسط عدد الحالات اللي بيحصل معاها تدخلات؟
  - كل يوم:
  - كل شهر
- ايه متوسط عدد جلسات التأهيل اللي بتعملها كل مدربة؟
  - كل يوم؟
  - كل شهر؟
- ايه أنواع الإعاقات اللي بتجيلكم في الوحدة؟ (ذهنية – حركية ...)
- كم عدد الأطفال\الأشخاص في كل نوع من أنواع الإعاقة تعاملتم معهم خلال الفترة السابقة؟
- ايه أنواع جلسات التأهيل اللي بتتقدم لكل نوع من الإعاقات؟

نوع الإعاقة	عدد المستفيدين	أنواع الجلسات المقدمة

- كم عدد الجلسات من كل نوع من أنواع جلسات التأهيل قدمتوها خلال الفترة السابقة؟ (تأهيل حركي – تأهيل لغوي ...)

نوع الجلسة (بصرف النظر عن نوع الإعاقة)	عدد الجلسات

- ايه الخدمات أو الأنشطة الأخرى اللي الوحدة بتقدمها للأطفال\الأشخاص ذوي الإعاقة و للأمهات؟
- ايه عدد جلسات أنواع الخدمات دي اللي قدمتوها خلال الفترة السابقة؟

نوع الخدمة\النشاط (بصرف النظر عن نوع الإعاقة)	عدد الجلسات

4.1.2. دليل مقابلة المشرف الفني \ منسق التأهيل

مقابلة مسؤول وحدة التأهيل

(أثناء الزيارة)

اسم الوحدة:

اسم المسؤول:

تاريخ المقابلة:

- بقالك قد ايه مسؤولة عن الوحدة؟
- ايه المؤهل بتاعك؟
- ايه التدريبات اللي أخدتيها؟
- ايه سابقة أعمالك في المجال؟
- ايه دورك و مسؤولياتك في المشروع؟
- ازاي بتقيّموا تقدم الأطفال من الحالات المختلفة؟
- ازاي بتقيّموا جودة الجلسات اللي بيتم تقديمها؟
- ايه التدريبات اللي أخدتها المدربات؟
- هل فيه برنامج للتدريب المستمر أو التدريب الداخلي في المشروع أو في الوحدة؟

- ازاي بتقيّموا أداء المدربات؟
- هل توجد عندكم اجراءات للاتاحة الفيزيقية و المعلوماتية و الاجتماعية؟ زي ايه؟
- هل يوجد تسجيل ورقي أو الكتروني للحالات اللي بتيجي و الجلسات اللي بتقدموها؟ ممكن نطلع عليها؟
- ايه محتويات ملف الطفل عندكم؟ ممكن نطلع عليها؟
- ايه اجراءات الأمن و السلامة عندكم؟
- ايه اجراءات و نظام الشكاوى عندكم؟
- ايه أهم التحديات اللي بتقابلوها في الشغل .. و بتأثر على شغلكم الفني (مع الأطفال – مع الأمهات – في الامكانيات – مع المجتمع ..)؟
- ايه أهم احتياجاتكم من الجوانب الفنية؟

4.1.3. دليل مقابلة أمهات الأطفال المستفيدين من خدمات الدمج

مقابلة جماعية\مجموعة نقاشية

مع الأمهات اللآتي تم دمج أبنائهن في التعليم

(عدد 5 أو 6 أمهات لحالات مختلفة)

أنا ...

أحب أتعرف عليكم .. أساميكم و أسامي أولادكم

- هل تعرفين ما هي المشكلة أو الصعوبة التي تؤثر على طفلك؟
- هو ابنك\بنتك مندمج في مدرسة؟
- في أي سنة؟
- طيب إزاي قدرتي تدخليه\ا المدرسة؟
- هل كان فيه صعوبات واجهتك علشان يدخل\تدخل المدرسة؟ إيه هي الصعوبات دي؟
- هل وحدة التأهيل المرتكز على المجتمع ساعدتك في الدمج؟ إزاي؟
- إيه هي الأنشطة اللي عملتها الوحدة لمساعدة ادماج طفلك؟ (أنشطة دامجة .. جلسات تنمية مهارات و قبل أكاديمي .. رحلات .. فعاليات في المجتمع .. ..)
- هو\هي عامل\ه إيه في المدرسة؟ هل فيه صعوبات بتقابله؟ إيه هي؟
- هل وحدة التأهيل المرتكز على المجتمع ساعدتك في نجاح ابنك في الدمج؟ إزاي؟
- (أنشطة دامجة .. جلسات تنمية مهارات و قبل أكاديمي .. رحلات .. فعاليات في المجتمع .. فعاليات في المدارس و الحضانات .. ..)

استمارة تفريغ مقابلة الأمهات

أسماء الأمهات و الأولاد:

1)

2)

3)

4)

5)

السؤال	الاستجابات
هل تعرفين ما هي المشكلة أو الصعوبة التي تؤثر على طفلك؟	

السؤال	الاستجابات
هو اينك\بنتك مندمج في مدرسة؟ في أي سنة؟	

السؤال	الاستجابات
هل كان فيه صعوبات واجهتك علشان يدخل\تدخل المدرسة؟ إيه هي الصعوبات دي؟	

السؤال	الاستجابات
هل وحدة التأهيل المرتكز على المجتمع ساعدتك في الدمج؟ إزاي؟	

السؤال	الاستجابات
هو\هي عامل\ه إيه في المدرسة؟ هل فيه صعوبات بتقابله؟ إيه هي؟	

السؤال	الاستجابات
هل وحدة التأهيل المرتكز على المجتمع ساعدتك في نجاح ابنك في الدمج؟ إزاي؟	

4.1.4. دليل مقابلة أمهات الأشخاص المستفيدين من الزيارات المنزلية

مقابلة جماعية\مجموعة نقاشية

مع الأمهات اللآتي يتلقين زيارات منزلية

(عدد 5 أو 6 أمهات لحالات مختلفة)

أنا ...

أحب أتعرف عليكم .. أساميكم و أسامي أولادكم

- هل تعرفين ما هي المشكلة أو الصعوبة التي تؤثر على طفلك؟
- منذ متى تحصلين على زيارات منزلية؟
- ما سبب أنك تحصلين على زيارة منزلية و لا تحضرين إلى الوحدة؟
- مسئولة التأهيل تأتي كام مرة فى الشهر للزيارة؟ وهل الأيام ثابتة أم تتغير؟ وماهى مدة الزيارة؟
- ماذا يحدث في الزيارة المنزلية؟
- ما الذي تقوم به المدربة؟
- ما الذي تقومين أنتي به؟
- ماذا تقومين به في الأيام التي لا تأتي فيها المدربة للزيارة المنزلية؟
- ماذا استفاد به ابنك من الزيارات المنزلية؟
- ماذا استفدتي أنتي من الزيارة المنزلية؟
- ما الذي يضايقك في الزيارة المنزلية؟

استمارة تفريغ مقابلة الأمهات

أسماء الأمهات و الأولاد:

(1

(2

(3

(4

(5

السؤال	الاستجابات
هل تعرفين ما هي المشكلة أو الصعوبة التي تؤثر على طفلك؟	
السؤال	الاستجابات
منذ متى تحصلين على زيارات منزلية؟ و ما سبب أنك تحصلين على زيارة منزلية و لا تحضرين إلى الوحدة؟	
السؤال	الاستجابات
مسئولة التأهيل تأتي كام مرة فى الشهر للزيارة؟ وهل الأيام ثابتة أم تتغير؟ وماهى مدة الزيارة؟	
السؤال	الاستجابات
ماذا يحدث في الزيارة المنزلية؟ ما الذي تقوم به المدربة؟ ما الذي تقومين أنتي به؟ ماذا تقومين به في الأيام التي لا تأتي فيها المدربة للزيارة المنزلية؟	
السؤال	الاستجابات
ماذا استفاد به ابنك من الزيارات المنزلية؟	

ماذا استفدتي أنتي من الزيارة المنزلية؟	
ما الذي يضايقك في الزيارة المنزلية؟	

4.1.5. أداة تقييم الجلسات

تقييم الجلسات الفنية

خطوات تقييم الجلسات الفنية:

الإطلاع على ملف الطفل:

هل يحتوي الملف على:

- المعلومات و المكونات المهمة؟
  - استمارة الاستقبال
  - أي تقارير أو فحوصات طبية
  - التقييمات التي تمت داخل أو خارج الوحدة
  - نتائج التقييمات التي وضعت خطط التدخل بناءً عليها (بالأرقام ما أمكن ذلك)
  - خطة\خطط التدخل
  - متابعات حالة الطفل (بالأرقام ما أمكن ذلك)
  - نتائج إعادة التقييمات (بالأرقام ما أمكن ذلك)
  - معلومات متعلقة بالأسرة و ذات صلة بالطفل و تطوره
- نتائج واضحة للتقييمات؟
- برنامج واضح للتدخلات المقدمة مناسب لتطور الطفل و حالته؟
- أهداف واضحة للجلسات الفنية مناسبة لتطور الطفل و حالته ؟
- رصد و متابعة لتطور الطفل و تقدمه من خلال ملاحظات و تقييمات و تقارير متتابعة؟
- رصد للصعوبات و التحديات التي يواجهها الطفل؟
- يظهر احراز الطفل لتقدم مناسب في المجالات المختلفة؟

مقابلة المدربة قبل الجلسة:

هل:

- تعرف حالة الطفل جيداً؟
- تدربت على الكفاءات اللازمة لوضع أهداف الجلسة و تنفيذها و متابعة حالة الطفل
- تعرف البرنامج الذي ستستخدمه؟
- حددت أهداف الجلسة بوضوح؟
- وضعت سيناريو و خطوات لتنفيذ الجلسة؟
- جهزت الأدوات \ الاستمارات اللازمة لتنفيذ الجلسة؟
- جهزت مكان تنفيذ الجلسة؟
- هل توجد الأدوات / الاستمارات في الوحدة لتنفيذ الجلسات المختلفة؟

ملاحظة الجلسة:

هل:

- ترحب المدربة بالطفل و الأم بطريقة لطيفة و تتعامل معهما بأسلوب ودود احترافي يساعد في تحقيق أهداف الجلسة و تقوية العلاقة معهما؟
- تنفذ سيناريو الجلسة بمرونة؟
- تحافظ على الطفل منتبهاً و مشاركاً؟
- تستجيب لتصرفات الطفل و طلباته بما لا يخل بسير الجلسة؟
- تعطي الطفل فترات مناسبة للراحة و\أو الحركة بين الأنشطة؟
- تنفذ أنشطة و تستخدم أدوات مناسبة لتحقيق الأهداف؟
- تربط بين الأهداف المختلفة في الأنشطة؟
- تشرح للأم ما يحدث؟
- تشرك الأم في الجلسة؟
- تنهي الجلسة في وقت مناسب و في وقتها المحدد سلفاً و بطريقة مخطط لها؟
- ملاحظة مهارات اكتسبها الطفل أو سلوكيات تم تغييرها منذ اشتراكه في الوحدة؟ نسبة الى التقييم الذى تم له من قبل (بالتطبيق)؟

مقابلة المدربة بعد الجلسة:

هل:

- تشرح للأم ما يجب عليها عمله في المنزل حتى موعد الجلسة المقبلة؟
- تكتب ملاحظاتها \ تقريرها بعد الجلسة في ملف الطفل؟

مقابلة أم الطفل\المرافق له:

هل:

- تحدد كيف انضمت لبرنامج الخدمات؟
- تعرف من أي تاريخ بدأت الجلسات؟
- تقدّر الجلسة و فوائدها؟
- تعرف ماذا استفاد الطفل من الجلسة؟
- تحدد أهم التغيرات التي حدثت في سلوك الطفل و مهاراته بسبب الجلسات خلال الفترة السابقة؟
- تشرح ما تقوم به في المنزل لدعم طفلها و تحسين أثر الجلسات؟
- تعبر عن مدى رضاها عما يقدم للطفل و مدى تأثيره؟
- تحدد ما هي الأنشطة التي شاركت فيها كأم بخلاف الجلسات؟
- تحدد ما هو تأثير البرنامج عليها هي شخصياً؟

استمارة تقييم الجلسات الفنية:

م	الأداء المراد تقييمه	ضعيف (0)	متوسط (1)	جيد (2)	الدرجة
الملف					
1	المعلومات و المكونات المهمة				
2	منظم من ناحية الأجزاء و التواريخ				
3	نتائج واضحة للتقييمات				

4	برنامج واضح للتدخلات المقدمة				
5	أهداف واضحة للجلسات الفنية				
6	رصد و متابعة لتطور الطفل و تقدمه				
7	رصد للصعوبات و التحديات التي يواجهها الطفل				
8	يظهر احراز الطفل لتقدم مناسب في المجالات المختلفة				
مقابلة المدربة قبل الجلسة					
9	تعرف حالة الطفل جيداً				
10	حددت البرنامج الذي ستستخدمه و أهداف الجلسة بوضوح				
11	وضعت سيناريو و خطوات لتنفيذ الجلسة				
12	جهزت الأدوات\الاستمارات اللازمة لتنفيذ الجلسة				
13	جهزت مكان تنفيذ الجلسة				
14	هل يوجد الأدوات / الاستمارات في الوحدة لتنفيذ الجلسات المختلفة؟				
ملاحظة الجلسة					
15	ترحب المدربة بالطفل و الأم بطريقة لطيفة				
16	تنفذ سيناريو الجلسة بمرونة				
17	تنفذ الجلسة بسهولة و يسر و روح طيبة				
18	تحافظ على الطفل منتبهاً و مشاركاً				
19	تستجيب لتصرفات الطفل و طلباته بما لا يخل بسير الجلسة				
20	تعطي الطفل فترات مناسبة للراحة و\أو الحركة بين الأنشطة				
21	تنفذ أنشطة و تستخدم أدوات مناسبة لتحقيق الأهداف				
22	تربط بين الأهداف المختلفة في الأنشطة				
23	تربط بين المجالات المختلفة في الأنشطة				
24	تشرح للأم ما يحدث أثناء الجلسة				
25	تشرك الأم في الجلسة				
26	تنهي الجلسة في وقت مناسب و بطريقة مخطط لها				
27	ملاحظة مهارات اكتسبها الطفل أو سلوكيات تم تغييرها منذ اشتراكه في الوحدة؟ نسبة الى التقييم الذى تم له من قبل (بالتطبيق)؟				
مقابلة المدربة بعد الجلسة					
28	تشرح للأم ما يجب عمله في المنزل حتى الجلسة المقبلة بما في ذلك الأدوات البديلة				
29	تكتب ملاحظاتها \ تقريرها بعد الجلسة في ملف الطفل				
30	تحفظ ملف الطفل				
مقابلة أم الطفل\المرافق له:					
31	تحدد كيف انضمت لبرنامج الخدمات				
32	تعرف من أي تاريخ بدأت الجلسات				
33	تقدّر الجلسة و فوائدها				
34	تعرف ماذا استفاد الطفل من الجلسة				
35	تحدد أهم التغيرات التي حدثت في سلوك الطفل و مهاراته بسبب الجلسات خلال الفترة السابقة				
36	تشرح ما تقوم به في المنزل لدعم طفلها و تحسين أثر الجلسات				
37	تشرح الأدوات البديلة التي تستخدمها مع الطفل في المنزل				
38	تعبر عن مدى رضاها عما يقدم للطفل و مدى تأثيره				

39	تحدد ما هي الأنشطة التي شاركت فيها كأم بخلاف الجلسات				
40	تحدد ما هو تأثير البرنامج عليها هي شخصياً				
مجموع الدرجات الكلي		\ 80		%	

4.1.6. أداة تقييم الإتاحة الفيزيقية

قائمة مختصرة لملاحظة الإتاحة الفيزيقية

لوحدات الرعاية الصحية الأولية

اسم الوحدة الصحية:

القائم بالملاحظة:

التاريخ:

م	عنصر التقييم	يوجد (2)	إلى حد ما (1)	لا يوجد (0)	الدرجة
1	الأبواب الخارجي الداخلية بعرض يسمح بمرور كرسي متحرك (لا يقل عن 90 سم) و ليس بها عتبة				
2	الممر من الشارع إلى الباب الخارجي بعرض لا يقل عن 90 سم و أرضيته ممهدة و صلبة و غير زلقة و ليس بها عقبات أو درجات سلم				
3	في حالة وجود سلم لابد أن يكون له درابزين في جانب على الأقل و لا تكون به درجات مكسورة.				
4	في حالة وجود سلم لابد أن يكون هناك منحدر بعرض 90 سم و زاوية ميل 1 : 12 على الأقل و درابزين على الجانبين و سور جانبي قوي و أرضيته صلبة و غير زلقة.				
5	الممرات و المسارات لا يوجد بها عوائق، و في حالة وجود عوائق؛ فيمكن الكشف عنها بواسطة العصا البيضاء (يستخدمها المكفوفون أثناء السير) (إرتفاع العوائق البارزة في المسار لا يقل عن 65 سم عن مستوى الأرض، و ارتفاع العوائق المعلقة من أعلى لا يقل عن 200 سم عن مستوى الأرض).				
6	يوجد كرسي متحرك عند مدخل الوحدة مخصص لاستخدام العملاء من ذوي الإعاقة الحركية.				
7	يوجد حمام واحد على الأقل بفتحة باب بعرض يسمح بمرور كرسي متحرك (لا يقل عن 90 سم) و يفضل أن تكون مساحته (150×150 سم أو 120 × 162,5 سم على الأقل) و بها مساند مثبتة.				
8	حجرات تقديم الخدمة بفتحة باب بعرض يسمح بمرور كرسي متحرك (لا يقل عن 90 سم)				
9	توجد وسيلة للاستعانة بمترجم لغة اشارة أو شخص يستطيع ترجمة الحوار للمستفيدين من ذوي الاعاقة السمعية				

10	توجد وسيلة للاستعانة بمرافق للمستفيدين من ذوي الاعاقة البصرية				
المجموع		الدرجة 16\		النسبة المئوية %	

4.2. وثائق مرجعية

4.2.1. تكوين الفريق الفني

فريق الدعم الفني لكل وحدة من داخل المكتب بالمحافظة

م	اسم الوحدة	المدير الفني للمكتب	المشرف الفني للوحدة	منسق تأهيل المكتب	مدير المكتب
1	وحدة المنشاة	آية صلاح	فاطمة عبدالعزيز	محمود فرغل	أحمد عرفة
2	وحدة فزارة	هدى أبو اليزيد	مصطفى صابر	سناء خليفة	سيد عبداللطيف
3	وحدة كوم المنصورة	صفية عبد المنعم	هدير أحمد	آيات علي	مروة يوسف

فريق الدعم الفني على مستوى المشروع

المحافظة	المدير الفني للمحافظة	أعداد الإشراف الفني	أعداد منسقي التأهيل	منسقي المشروع	المدير الفني للمشروع	مدير المكتب
بني سويف	دعاء سيد تشرف على (4) وحدات بالمحافظة	**4**	**2**	آيات علي تشرف على (4) وحدات بالمحافظة	هدى أبو اليزيد	سيد عبداللطيف
سوهاج	آية صلاح تشرف على (5) وحدات بالمحافظة	**3**	**2**	سناء خليفة تشرف على (5) وحدات بالمحافظة		
أسيوط	صفية عبد المنعم تشرف على (6) وحدات بالمحافظة	**5**	**2**	آيات علي تشرف على (6) وحدات بالمحافظة		

	هدى أبو اليزيد تشرف على (15) وحدة بالمحافظة	8		سناء خليفة تشرف على (15) وحدة بالمحافظة		
إجمالي		19	6	2	1	1

4.2.2. التوصيف الوظيفي للفريق الفني

مهام فريق الدعم الفني لوحدات برنامج وصول

مدير المشروع

1. التواصل مع الجهة الشريكة.
2. وضع خطة العمل بالمشروع.
3. استلام التقارير الشهرية من منسقي تأهيل المشروع.
4. عمل تقرير شهري و تقارير مرحلية للمشروع.
5. متابعة العمل بالمشروع.
6. مراجعة الأعمال فنيًا مع المدير الفني وفقًا للخطة التنفيذية للمشروع وماليًا مع محاسب المشروع وفقًا للموازنة المالية.

المدير الفني للمشروع

1. وضع الخطط الفنية للتدريبات والورش بالتعاون مع المديرين الفنيين للمكاتب ومنسقي الوحدات.
2. متابعة تنفيذ التدريبات النظرية والعملية بالمحافظات المختلفة بالتعاون مع المديرين الفنيين للمكاتب.
3. المشاركة في إعداد واعتماد المواد العلمية للتدريبات والورش.
4. المشاركة في إعداد استمارات العمل الفنية بالتعاون مع أعضاء الإدارة الفنية واعتمادها.
5. متابعة إعداد الأدلة الاسترشادية للعمل الفني بالمشروع.
6. متابعة خطة عمل المشروع وفق المستهدفات المخطط لها.
7. التعاون مع مدير المشروع لإعداد التقارير السنوية والدورية.
8. تنفيذ زيارات متابعة للوحدات وفق الزيارات المستهدفة.
9. متابعة الترشيحات (لمسئولات التأهيل / المحاضرين في البرنامج التدريبي / مقدمي الدعم بالوحدات) بالتعاون مع المديرين الفنيين ومديري مراكز كيان .

مدير المكتب

1. اختيار المناطق المستهدفة
2. عمل الشراكات مع الجمعيات.
3. تنفيذ الاجتماعات الدورية مع الجمعيات واللجان.
4. متابعة عمل المنسق المجتمعي للمكتب مع الوحدات.
5. مراجعة واعتماد التقارير الشهرية والدورية.
6. اختيار (تكوين اللجان المجتمعية) بالمناطق المستهدفة.
7. التعامل مع الجهات الخارجية (مؤسسات حكومية وأهلية).
8. مراجعة واعتماد بنود الصرف طبقًا للميزانية (التسويات).
9. تنفيذ زيارات متابعة دورية للوحدات.
10. التواصل المباشر مع الجمعيات الشريكة.
11. وضع واعتماد الخطط لوحدات المكتب.
12. حضور اجتماعات المشروع

المدير الفني للمكتب

1. تنفيذ زيارات المتابعة والدعم لوحدات التأهيل التابعة للمكتب.
2. الإشراف على تطبيق المعايير الفنية في جميع أنشطة المشروع .
3. التعاون مع المدير الفني للمشروع في إعداد استمارات العمل الفني للمشروع .
4. التعاون مع مدير المكتب في متابعة خطة عمل المكتب لدعم الوحدات التأهيلية.
5. مكون التدريب.

(المشاركة في التدريبات - متابعة تنفيذ التدريبات - اختيار المحاضرين المرشحين لتقديم التدريبات - ومراجعة نتائج استبيانات تقييم التدريبات - مراجعة المواد العلمية والعروض التوضيحية قبل تنفيذ التدريبات بالتعاون مع منسقي الوحدات المتخصصة).

6. متابعة خطة التدريب العملي .
7. التعاون مع منسق التأهيل والإشراف الفني بالمكتب لتقييم أداء مسئولات التأهيل.
8. حضور الاجتماعات واللقاءات الدورية مع إدارة المشروع .
9. مراجعة قصص النجاح من خلال التعاون مع الإشراف الفني ومنسق التأهيل.

منسقو التأهيل بالمكتب

1. تنفيذ زيارات متابعة للوحدات.

2. متابعة تنفيذ الخطة والمستهدفات بكل وحدة.
3. التواصل مع منسق المشروع وإرسال التقارير والبيانات المطلوبة.
4. إعداد ورصد قصص النجاح بالتعاون مع الإشراف الفني و مسؤولات التأهيل.
5. مراجعة بيانات رصد احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة (المستفيدين) و المشاركة في تحليل قواعد البيانات.
6. تنسيق التدريبات وفق المعايير المطلوبة.

- إعداد تقرير عن كل برنامج تدريبي.
- توثيق التدريبات.
- متابعة استبيانات تقييم البرامج التدريبية.

7. متابعة العمل الإداري بالوحدات (حضور وانصراف/خطوط سير/.....).
8. الإشراف والتعاون في تنفيذ الأنشطة بالوحدات .
9. توثيق الأنشطة.

منسق المشروع

1. التواصل مع منسقي التأهيل بالمكاتب لجمع البيانات المطلوبة ومتابعة سير أنشطة المشروع .
2. إعداد التقارير الدورية ورفعها للمدير الفني للمشروع ومدير المشروع .
3. متابعة وحدات محافظة أسيوط بشكل مباشر .
4. متابعة تنفيذ التدريبات بالمحافظات الثلاثة بالتعاون مع المدير الفني للمشروع والمديرين الفنيين للمكاتب ومنسقي التأهيل ومديري المكاتب .
5. التعاون مع مدخلي البيانات بالمشروع في عمليات جمع البيانات ومراجعتها .
6. التعاون مع المدير الفني للمشروع ومنسق وحدات التأهيل بالجمعية وفق احتياجات سير العمل بالمشروع.

المشرف الفني على الوحدة

1. تنفيذ زيارات متابعة دورية وفق مستهدفات الخطة وإعداد التقارير المنفصلة لكل زيارة.
2. مدة الزيارة (يوم عمل كامل)، رفع جميع التقارير لمنسق التأهيل.
3. تقديم الدعم والمتابعة الفنية من خلال التدريب على رأس العمل داخل الوحدات .
4. مراجعة جميع الملفات الفنية للمستفيدين - الأنشطة - دراسات الحالة - قصص النجاح .
5. متابعة خطة الشهر ومراجعة المستهدفات المخطط لها .
6. تقديم الدعم والمتابعة للأنشطة والخدمات خارج الوحدة (الزيارات المنزلية - الأنشطة المجتمعية ...الخ .
7. توثيق جميع الأنشطة داخل وخارج الوحدة وزيارات المتابعة والدعم.

8. رصد وإعداد قصص النجاح.
9. متابعة العمل وفق معايير الجودة الفنية المقررة.
10. التعاون مع المدير الفني للمكتب ومنسق التأهيل لتقييم أداء مسئولات التأهيل .

منسقو الوحدات المتخصصة :

1. حضور الاجتماعات واللقاءات الدورية مع إدارة المشروع وفق الاحتياج.
2. متابعة المشاركين من فريق العمل بالوحدات المتخصصة في تنفيذ البرنامج التدريبي بالتعاون مع المدير الفني للمكتب ومدير المكتب والإشراف الفني .
   - عقد اجتماعات مع المحاضرين لتنسيق التدريب ومشاركة النتائج للمعنيين .
   - مراجعة العرض التوضيحي بالتعاون مع المدير الفني للمكتب والمشروع .
   - متابعة عمليات التدريب وتقديم الدعم الكافي بمشاركة المعنيين .
   - تقديم الدعم بخصوص إعداد استمارات العمل / نموذج الخطة الفردية ....الخ وفق الاحتياج .
3. المشاركة في تنفيذ الزيارات للوحدات بالتنسيق المباشر مع المدير الفني للمشروع .
4. متابعة تنفيذ ورش الأسر (الموضوعات المتخصصة فقط) بالتنسيق مع المدير الفني للمشروع ومنسقي المشروع .
5. القسم النفسي مسئول عن التعاون مع مدير المشروع والمدير الفني للمشروع ومديري المكاتب لتنظيم عمليات التقييمات التشخيصية للمستفيدين وتجهيز الأدوات اللازمة لذلك وفق المستهدفات المحددة بخطة المشروع .
6. قسم التخاطب مسئول عن التعاون المباشر مع منسق التأهيل بالمكتب ومدير المكتب والمدير الفني للمكتب لتقديم الدعم بخصوص الحالات.
7. وحدة المنتسوري مسئولة عن التعاون المباشر مع منسق التأهيل بالمكتب ومدير المكتب والمدير الفني للمكتب لتقديم الدعم بخصوص الحالات.
8. وحدة التكامل مسئولة عن التعاون المباشر مع منسق التأهيل بالمكتب ومدير المكتب والمدير الفني للمكتب لتقديم الدعم بخصوص الحالات.